Tema: Patología Biliar

Subtema: Íleo biliar

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Femenina de 78 años de edad, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 y colelitiasis diagnosticada hace 10 años que rechazó tratamiento quirúrgico. Es traída al servicio de urgencias por sus familiares refiriendo dolor abdominal tipo cólico, difuso, acompañado de distensión abdominal progresiva, náuseas y vómitos de características fecaloides de 3 días de evolución. Refiere no haber canalizado gases ni evacuado en las últimas 72 horas. A la exploración física: signos vitales estables, paciente deshidratada (mucosas secas). Abdomen globoso, timpánico a la percusión, con peristalsis metálica aumentada en frecuencia. Se solicita una radiografía simple de abdomen en bipedestación que muestra dilatación de asas de intestino delgado con niveles hidroaéreos, presencia de gas en el árbol biliar y una imagen radiopaca redondeada de 3 cm en la fosa ilíaca derecha.

Pregunta 1

Los tres hallazgos radiológicos descritos en este paciente son patognomónicos de esta complicación litiásica. ¿Qué nombre recibe esta tríada radiológica?

A) Tríada de Charcot

B) Tríada de Rigler *

C) Tríada de Beck

D) Tríada de Mackler

Retroalimentación:

La Tríada de Rigler es el sello radiológico del íleo biliar en una radiografía simple de abdomen. Consiste en: 1) Signos de obstrucción de intestino delgado (niveles hidroaéreos), 2) Neumobilia o aerobilia (gas en la vía biliar por la fístula colecistoentérica) y 3) Visualización de un cálculo biliar ectópico (radiolúcido o radiopaco) en el tracto intestinal.

Pregunta 2

Desde el punto de vista anatómico y fisiopatológico, ¿cuál es el sitio más frecuente donde el cálculo biliar se impacta y causa la obstrucción mecánica del tubo digestivo?

A) Válvula ileocecal (Íleon terminal) *

B) Segunda porción del duodeno

C) Ángulo de Treitz

D) Válvula de Houston (Recto)

Retroalimentación:

El íleo biliar ocurre cuando un lito grande (generalmente >2.5 cm) erosiona la pared de la vesícula hacia el intestino (frecuentemente el duodeno) creando una fístula. El lito viaja por el intestino delgado hasta que se atora en el punto anatómico más estrecho, que es el íleon terminal (válvula ileocecal), en aproximadamente el 60-70% de los casos.

Pregunta 3

Considerando la edad avanzada de la paciente y el riesgo quirúrgico, ¿cuál es el manejo quirúrgico de urgencia de primera elección recomendado para resolver el cuadro obstructivo?

A) Colecistectomía laparoscópica y cierre de la fístula

B) Enterolitotomía exclusiva (extracción del lito mediante enterotomía) *

C) Resección intestinal del íleon con anastomosis primaria

D) Derivación biliodigestiva en Y de Roux

Retroalimentación:

El objetivo principal en una paciente anciana con íleo biliar es resolver la obstrucción intestinal mecánica que amenaza la vida con la menor morbilidad posible. El procedimiento de elección es la enterolitotomía (abrir el intestino, extraer el lito y cerrar). La resolución de la fístula colecistoentérica y la colecistectomía en el mismo tiempo quirúrgico se asocian a una alta mortalidad, por lo que se reservan solo para pacientes jóvenes y muy estables, o se difieren para un segundo tiempo si la paciente presenta síntomas biliares posteriores.

Tema: Intoxicaciones

Subtema: Toxíndromes (Anticolinérgico)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 18 años es llevado a urgencias por sus amigos después de haber ingerido un té de flor de campana (Datura stramonium) con fines recreativos. A la exploración física, el paciente se encuentra con agitación psicomotriz, delirio y murmullos incomprensibles ("loco como sombrerero"). Su piel está intensamente eritematosa ("rojo como betabel") y completamente seca ("seco como un hueso"), con temperatura de 39°C. Se observa midriasis bilateral arreactiva ("ciego como murciélago") y presenta taquicardia de 140 lpm con globo vesical palpable por retención urinaria.

Pregunta 1

Ante este cuadro clásico de intoxicación anticolinérgica pura y severa con manifestaciones centrales (delirio) y periféricas, ¿cuál es el antídoto específico de elección, el cual debe ser administrado con precaución y monitorización cardiaca?

A) Sulfato de Atropina

B) Fisostigmina *

C) Pralidoxima

D) Flumazenilo

Retroalimentación:

La fisostigmina es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa capaz de cruzar la barrera hematoencefálica. Al inhibir esta enzima, aumenta los niveles de acetilcolina en la hendidura sináptica, compitiendo y desplazando al agente anticolinérgico de los receptores muscarínicos, revirtiendo así tanto los síntomas centrales (delirio, coma) como los periféricos.

Tema: Patología arterial y venosa

Subtema: Tromboembolia Pulmonar (TEP)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Femenina de 65 años, quien se encuentra en su cuarto día de postoperatorio de una artroplastia total de rodilla derecha. De forma súbita, mientras deambulaba al baño, presenta disnea severa, dolor torácico de características pleuríticas, diaforesis y sensación de muerte inminente. A la exploración física: TA 100/60 mmHg, FC 120 lpm, FR 28 rpm, SatO2 86% al aire ambiente. A la auscultación pulmonar no se integran síndromes pleuropulmonares y a la auscultación cardiaca se ausculta un reforzamiento del segundo ruido pulmonar (P2).

Pregunta 1

Se solicita un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones en la sala de urgencias. Aunque se describe clásicamente el patrón S1Q3T3 (complejo de McGinn-White), este solo se presenta en el 20% de los casos. ¿Cuál es el hallazgo electrocardiográfico MÁS FRECUENTE en pacientes con Tromboembolia Pulmonar?

A) Bloqueo completo de rama derecha

B) Fibrilación auricular de nueva aparición

C) Taquicardia sinusal *

D) Inversión de ondas T en derivaciones V1 a V4

Retroalimentación:

La taquicardia sinusal es la alteración electrocardiográfica más frecuente en pacientes con TEP agudo, presentándose en más del 70% de los casos como una respuesta compensatoria a la hipoxemia y la disfunción del ventrículo derecho. El patrón S1Q3T3 (ondas S profundas en DI, ondas Q patológicas en DIII y ondas T invertidas en DIII) es un signo clásico de cor pulmonale agudo, pero es poco sensible.

Pregunta 2

Al encontrarse la paciente hemodinámicamente estable (presión sistólica > 90 mmHg), con una probabilidad clínica alta de TEP (Escala de Wells > 6), ¿cuál es el estudio de imagen de elección y estándar de oro para confirmar el diagnóstico anatómico?

A) Gammagrafía V/Q (Ventilación/Perfusión)

B) Angiotomografía Computarizada (AngioTAC) pulmonar multicorte *

C) Ecocardiograma transtorácico

D) Dímero D cuantitativo

Retroalimentación:

La AngioTAC de arterias pulmonares es el estándar de oro actual y el estudio de imagen de primera línea para confirmar la Tromboembolia Pulmonar en pacientes hemodinámicamente estables, permitiendo visualizar los defectos de llenado (trombos) en las arterias pulmonares principales y segmentarias. El Dímero D no tiene utilidad cuando la probabilidad pretest ya es alta, pues solo sirve para descartar (alto valor predictivo negativo) en pacientes con baja probabilidad.

Tema: ETS

Subtema: Chancroide

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 28 años, sexualmente activo con múltiples parejas, acude a consulta externa quejándose de la aparición de úlceras dolorosas en el pene de 5 días de evolución. A la exploración física, se observan tres úlceras en el prepucio y surco balanoprepucial; las lesiones miden entre 1 y 2 cm, tienen bordes irregulares, base eritematosa y están recubiertas por un exudado purulento, grisáceo y maloliente. Son exquisitamente dolorosas a la manipulación. Además, se palpa una gran adenopatía inguinal unilateral derecha, dolorosa y fluctuante (bubón inguinal).

Pregunta 1

Con base en las características morfológicas y el dolor característico de las úlceras, ¿cuál es el agente bacteriano causante de esta enfermedad de transmisión sexual?

A) Treponema pallidum

B) Chlamydia trachomatis (serotipos L1-L3)

C) Haemophilus ducreyi *

D) Virus del Herpes Simple tipo 2 (VHS-2)

Retroalimentación:

El chancroide (chancro blando) es causado por el bacilo gramnegativo Haemophilus ducreyi. Su presentación clínica distintiva son las úlceras genitales múltiples, profundas, sucias (purulentas) y muy dolorosas, acompañadas clásicamente de linfadenopatía inguinal dolorosa que puede supurar (bubón). En contraste, el chancro sifilítico (sífilis primaria) es una úlcera única, de bordes limpios, indurada y completamente indolora.

Tema: Introducción Oftalmología

Subtema: Celulitis Periorbitaria vs Orbitaria

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Escolar masculino de 8 años de edad, con antecedente de una sinusitis etmoidal bacteriana mal tratada hace 10 días. Es llevado a urgencias oftalmológicas por presentar fiebre alta de 39°C, edema palpebral severo, eritema y calor en el ojo derecho. A la exploración física, el paciente presenta el ojo derecho desplazado hacia adelante (proptosis/exoftalmos), inyección conjuntival marcada (quemosis) e incapacidad para mover el ojo derecho en ninguna dirección (oftalmoplejía total). Refiere dolor intenso al intentar movilizar el ojo y la agudeza visual de ese lado ha disminuido a 20/200.

Pregunta 1

De acuerdo con los hallazgos exploratorios, ¿cuál es la complicación orbitaria infecciosa que presenta el paciente y que requiere tratamiento intravenoso urgente?

A) Celulitis periorbitaria (preseptal)

B) Dacriocistitis aguda

C) Celulitis orbitaria (postseptal) *

D) Endoftalmitis endógena

Retroalimentación:

La celulitis orbitaria es una infección profunda que afecta los tejidos situados por detrás del septum orbitario. Los signos clínicos cardinales que la distinguen de una simple celulitis periorbitaria (que solo afecta los párpados) son la presencia de

proptosis (exoftalmos), oftalmoplejía (restricción dolorosa de los movimientos oculares por inflamación de los músculos extraoculares) y disminución de la agudeza visual por compromiso del nervio óptico. Es una emergencia médica.

Pregunta 2

Dada la anatomía de los senos paranasales, ¿cuál es la estructura sinusal cuya inflamación e infección se extiende con mayor frecuencia (por contigüidad a través de la lámina papirácea) para causar una celulitis orbitaria, especialmente en niños?

A) Seno maxilar

B) Celdillas etmoidales *

C) Seno frontal

D) Seno esfenoidal

Retroalimentación:

Las celdillas etmoidales (seno etmoidal) están separadas de la cavidad orbitaria únicamente por una capa ósea extremadamente delgada conocida como "lámina papirácea", la cual presenta múltiples dehiscencias naturales. Por ello, la rinosinusitis etmoidal es la causa más común (hasta en el 90% de los casos) de extensión de la infección hacia la órbita en la población pediátrica.

Tema: ATLS P1

Subtema: Trauma Torácico (Hemotórax masivo)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 35 años es traído a la sala de choque tras sufrir una herida por proyectil de arma de fuego en el hemitórax derecho, a nivel del quinto espacio intercostal línea axilar media. A su ingreso, el paciente presenta datos francos de choque hipovolémico: palidez extrema, diaforesis, TA 70/40 mmHg, FC 140 lpm y FR 30 rpm. A la exploración del tórax, la tráquea está central, no hay ingurgitación yugular. A la auscultación, los ruidos respiratorios están completamente abolidos en el hemitórax derecho, y a la percusión se encuentra matidez franca en ese mismo lado.

Pregunta 1

Por los datos clínicos (choque + abolición de ruidos + matidez), se diagnostica un hemotórax masivo derecho. Se procede a colocar una sonda endopleural (tubo de

tórax) en el quinto espacio intercostal línea axilar media. ¿Cuál es el criterio de volumen de drenaje sanguíneo inmediato al colocar la sonda que indica la necesidad de una toracotomía de urgencia en quirófano?

A) Salida inicial de 500 cc de sangre

B) Salida inicial de 800 cc de sangre

C) Salida inicial mayor a 1,500 cc de sangre *

D) Cualquier cantidad de sangre es indicación de cirugía inmediata

Retroalimentación:

El ATLS establece que las indicaciones para una toracotomía de urgencia en un hemotórax masivo son: la salida inicial de >1,500 ml de sangre inmediatamente después de la colocación de la sonda endopleural, o un drenaje continuo de >200 ml/hora durante 2 a 4 horas consecutivas, sumado a inestabilidad hemodinámica persistente.

Pregunta 2

Desde el punto de vista semiológico, ¿cuál es el signo clínico clave a la exploración física que permitió diferenciar este cuadro de un neumotórax a tensión en la sala de choque antes de colocar la sonda?

A) La ausencia de ruidos respiratorios

B) La hipotensión severa

C) La matidez a la percusión *

D) La taquipnea

Retroalimentación:

Tanto el neumotórax a tensión como el hemotórax masivo causan choque (uno obstructivo y el otro hipovolémico) y abolición de ruidos respiratorios en el lado afectado. La clave clínica diferencial en la percusión torácica es que el hemotórax produce matidez (por la presencia de líquido/sangre), mientras que el neumotórax a tensión produce hiperresonancia o timpanismo (por la acumulación de aire a presión).

Tema: Patología Infecciosa / Rinología y faringe

Subtema: Papilomatosis laríngea (Papilomatosis respiratoria recurrente)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Preescolar masculino de 3 años es llevado a la consulta de otorrinolaringología por su madre, quien refiere que el niño ha presentado cambios en su voz (disfonía) de varios meses de evolución, la cual ha progresado a un llanto débil. En las últimas semanas, la madre nota un ruido agudo al tomar aire (estridor inspiratorio) cuando el niño llora o hace esfuerzo. No ha presentado fiebre ni cuadros de infección aguda. Se le realiza una nasofibrolaringoscopia flexible encontrando múltiples lesiones exofíticas, rosadas, con aspecto de "frambuesa" o "coliflor", localizadas en ambas cuerdas vocales y la banda ventricular.

Pregunta 1

De acuerdo con la epidemiología y las características de las lesiones, ¿cuáles son los serotipos virales directamente responsables de causar esta patología (la neoplasia benigna más común de la laringe en niños)?

A) Virus del Papiloma Humano (VPH) 16 y 18

B) Virus de Epstein-Barr (VEB)

C) Virus del Papiloma Humano (VPH) 6 y 11 *

D) Virus Sincitial Respiratorio (VSR)

Retroalimentación:

La papilomatosis respiratoria recurrente infantil es causada por el contagio en el canal de parto con los serotipos de bajo riesgo del Virus del Papiloma Humano (VPH), predominantemente los serotipos 6 y 11. Causa lesiones exofíticas verrugosas ("en coliflor") que pueden obstruir la vía aérea. Los serotipos 16 y 18 son de alto riesgo oncogénico (Cáncer cervicouterino y orofaríngeo).

Shutterstock

Tema: Cirugía Oncología

Subtema: Cáncer de Recto

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Femenina de 62 años acude a consulta por referir sangrado rectal fresco (hematoquecia) mezclado con las heces, pujo y sensación de evacuación incompleta (tenesmo rectal) de 4 meses de evolución. A la exploración física, el tacto rectal evidencia una masa indurada, friable, que ocupa la mitad de la circunferencia luminal, localizada en el recto inferior, a solo 3 centímetros del margen anal. Se realiza colonoscopia con biopsia que confirma un adenocarcinoma de recto moderadamente diferenciado.

Pregunta 1

Para realizar una estadificación locorregional precisa (evaluar la profundidad de invasión T y el estado ganglionar N), ¿cuál es el estudio de imagen pélvico de elección que debe solicitarse obligatoriamente antes de definir el tratamiento?

A) Tomografía por Emisión de Positrones (PET-CT)

B) Ultrasonido pélvico transabdominal

C) Resonancia Magnética (RM) pélvica de alta resolución *

D) Radiografía simple de pelvis

Retroalimentación:

La Resonancia Magnética de pelvis de alta resolución es el estándar de oro absoluto para la estadificación locorregional del cáncer de recto. Permite evaluar con gran precisión la invasión del tumor a través de las capas del recto (muscularis propia, grasa mesorrectal), la afectación de los ganglios linfáticos perirrectales y la distancia del tumor a la fascia mesorrectal (margen circunferencial).

Pregunta 2

La Resonancia Magnética reporta un tumor estadío cT3 N1 (invasión a la grasa perirrectal y 2 ganglios sospechosos). De acuerdo con la GPC para el cáncer de recto en estas etapas (localmente avanzado), ¿cuál es el abordaje terapéutico inicial recomendado previo a la cirugía?

A) Resección quirúrgica inmediata

B) Quimioterapia paliativa exclusiva

C) Quimiorradioterapia neoadyuvante (preoperatoria) *

D) Radioterapia adyuvante (postoperatoria) exclusiva

Retroalimentación:

A diferencia del cáncer de colon, los tumores de recto localmente avanzados (estadio II y III, es decir T3, T4 o N positivo) tienen una indicación formal para recibir quimiorradioterapia neoadyuvante antes de la cirugía. Esto tiene el objetivo de disminuir el tamaño tumoral (downstaging), aumentar las tasas de preservación de los esfínteres y disminuir drásticamente el riesgo de recurrencia local.

Pregunta 3

Finalizado el tratamiento neoadyuvante, la paciente es programada para cirugía definitiva. Debido a que el tumor se localiza en el tercio inferior del recto (a 3 cm del margen anal) e invade el complejo de los esfínteres, ¿cuál es el procedimiento quirúrgico de elección indicado?

A) Resección anterior baja de recto con anastomosis coloanal

B) Resección abdominoperineal (Operación de Miles) con colostomía definitiva *

C) Colectomía subtotal con ileorrectoanastomosis

D) Resección transanal endoscópica (TEM)

Retroalimentación:

Cuando un cáncer de recto inferior está a menos de 5 cm del margen anal y compromete el complejo esfinteriano (imposibilitando dejar un margen distal libre de enfermedad sin destruir el esfínter), el procedimiento estándar es la Resección Abdominoperineal (Procedimiento de Miles). Esto implica extirpar el recto, el canal anal y el aparato esfinteriano, dejando a la paciente con una colostomía terminal definitiva en el abdomen.

Tema: Patología cámara posterior

Subtema: Uveítis Anterior

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 30 años, con antecedente de dolor lumbar crónico inflamatorio (diagnosticado con espondilitis anquilosante). Acude a urgencias oftalmológicas por presentar inicio agudo de enrojecimiento intenso, dolor ocular severo y fotofobia extrema en el ojo izquierdo, acompañado de lagrimeo y visión borrosa. A la exploración con la lámpara de hendidura, se observa inyección periquerática (anillo rojo alrededor de la córnea). La pupila izquierda se encuentra contraída (miosis) en comparación con la derecha. Al observar la cámara anterior, se aprecia el fenómeno de Tyndall positivo (células inflamatorias flotando en el humor acuoso) y depósitos blanquecinos en el endotelio corneal (precipitados queráticos).

Pregunta 1

Por las características clínicas y los hallazgos patognomónicos en la lámpara de hendidura, ¿cuál es el diagnóstico correcto?

A) Glaucoma agudo de ángulo cerrado

B) Queratitis bacteriana

C) Uveítis anterior aguda (Iridociclitis) *

D) Conjuntivitis viral

Retroalimentación:

La uveítis anterior aguda se caracteriza por dolor profundo, fotofobia severa, ojo rojo (inyección ciliar) y miosis (por espasmo del esfínter del iris). El hallazgo patognomónico es la presencia de proteínas (flare) y células en la cámara anterior (efecto Tyndall), junto con los precipitados queráticos. Tiene una fortísima asociación sistémica con enfermedades autoinmunes portadoras del HLA-B27, como la espondilitis anquilosante.

Pregunta 2

Para evitar la formación de sinequias posteriores (adherencias del iris inflamado al cristalino) y aliviar el dolor causado por el espasmo ciliar, ¿qué familia de fármacos tópicos debe instilarse obligatoriamente en conjunto con los corticosteroides tópicos?

A) Agonistas alfa-2 adrenérgicos (Brimonidina)

B) Midriáticos / Ciclopléjicos (Ciclopentolato o Atropina) *

C) Análogos de prostaglandinas (Latanoprost)

D) Beta bloqueadores (Timolol)

Retroalimentación:

El tratamiento de la uveítis anterior aguda consiste en corticosteroides tópicos (para apagar la inflamación) y gotas midriáticas-ciclopléjicas. El ciclopléjico paraliza el músculo ciliar (aliviando drásticamente el dolor) y dilata la pupila (midriasis), lo que aleja el borde del iris del cristalino, previniendo la formación de sinequias posteriores que podrían llevar a complicaciones graves como glaucoma secundario.

Tema: Mordeduras y picaduras

Subtema: Mordedura de Serpiente (Viperidae)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 45 años, de ocupación agricultor, es traído al hospital rural tras haber sido mordido en la pantorrilla derecha hace 2 horas por una serpiente identificada como "nauyaca". A su ingreso, el paciente se queja de dolor insoportable en la extremidad. A la exploración física, se aprecian dos marcas de colmillos en la cara lateral de la pierna, con sangrado activo. Presenta un edema severo que ya abarca hasta el tercio medio del muslo derecho, acompañado de equimosis y múltiples flictenas de contenido hemorrágico. Los signos vitales muestran TA 90/50 mmHg, FC 115 lpm. Exámenes de laboratorio urgentes reportan plaquetas en 45,000/mm^3, Tiempos de Protrombina (TP) y Tromboplastina (TTPa) prolongados al infinito (incoagulables), y fibrinógeno severamente disminuido.

Pregunta 1

De acuerdo con la sintomatología local devastadora y las alteraciones sistémicas de la coagulación, ¿a qué familia biológica pertenece la serpiente causal de este toxíndrome (Crotoxina / Veneno Hemotóxico)?

A) Elapidae (Serpiente de coral)

B) Viperidae (Crotálidos) *

C) Colubridae

D) Hydrophiinae

Retroalimentación:

Las serpientes de la familia Viperidae (crotálidos), que incluyen a la cascabel y a la nauyaca (Bothrops), producen un veneno predominantemente citotóxico y hemotóxico. Provocan necrosis tisular local severa, edema masivo y un síndrome de coagulación intravascular diseminada (CID) por consumo de factores. Las Elapidae (coralillos) producen un veneno neurotóxico que causa parálisis flácida respiratoria, sin inflamación o daño local importante.

Pregunta 2

Según la clasificación de Christopher-Rodning para el envenenamiento por mordedura de crotálido, la presencia de edema severo que rebasa la extremidad y la coagulopatía grave (incoagulabilidad), ¿en qué grado de envenenamiento sitúan a este paciente?

A) Grado I (Leve)

B) Grado II (Moderado)

C) Grado III (Grave) *

D) Grado IV (Muy grave / Choque irreversible)

Retroalimentación:

La clasificación de Christopher-Rodning Grado III se define por la presencia de dolor intenso, edema que afecta toda la extremidad e involucra el tronco, síntomas sistémicos graves (hipotensión) y alteraciones marcadas en los estudios de laboratorio (coagulopatía de consumo, CID, plaquetopenia).

Pregunta 3

Ante este nivel de envenenamiento, ¿cuál es el tratamiento biológico específico y la posología inicial recomendada por la Norma Oficial Mexicana y la GPC?

A) Observación y profilaxis tetánica exclusiva

B) Administración intravenosa de 1 a 2 frascos de faboterápico polivalente antiviperino

C) Administración intravenosa de 6 a 8 frascos (o más) de faboterápico polivalente antiviperino *

D) Aplicación de torniquete arterial y succión mecánica del veneno

Retroalimentación:

Para un envenenamiento Grado III por viperidos, la GPC recomienda el uso inmediato de múltiples frascos (usualmente de 6 a 8 como dosis inicial, pudiendo ser mucho más alta dependiendo de la respuesta) del antiveneno (faboterápico polivalente antiviperino). El uso de torniquetes, incisiones, succión o hielo están absolutamente contraindicados porque empeoran la isquemia tisular y aumentan el riesgo de amputación.

Tema: Patología Gástrica

Subtema: Dispepsia Funcional

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 28 años, sin antecedentes de importancia, acude por referir dolor y ardor en epigastrio, así como saciedad temprana y plenitud posprandial, de 4 meses de evolución, presentándose al menos 3 días a la semana. Niega pérdida de peso, vómitos, disfagia o sangrado gastrointestinal. Cuenta con una endoscopia superior reciente que se reporta completamente normal, sin evidencia de úlceras o lesiones estructurales, y prueba de H. pylori negativa.

Pregunta 1

Con base en los Criterios de Roma IV, al no existir evidencia de enfermedad estructural que explique los síntomas, ¿cuál es el diagnóstico definitivo de la paciente?

A) Úlcera péptica no complicada

B) Síndrome de Zollinger-Ellison

C) Dispepsia funcional *

D) Gastritis crónica atrófica

Retroalimentación:

La dispepsia funcional se diagnostica con base en los Criterios de Roma IV (presencia de plenitud posprandial, saciedad temprana, dolor o ardor epigástrico) cuando se ha realizado una endoscopia y se ha descartado categóricamente cualquier causa orgánica, estructural o metabólica (como infección por H. pylori o úlceras) que explique la sintomatología.

Getty Images

Tema: Patología Diverticular

Subtema: Diverticulosis

Dificultad: Baja

Caso clínico (Medio):

Masculino de 65 años, asintomático, acude a su chequeo médico de rutina. Refiere una dieta baja en fibra y antecedente de estreñimiento crónico. Como parte del escrutinio para cáncer de colon por su edad, se le realiza una colonoscopia de tamizaje. Durante el estudio, no se observan pólipos ni masas sospechosas, pero se reporta la presencia de múltiples invaginaciones saculares de la mucosa y submucosa a través de las capas musculares de la pared del colon, localizadas predominantemente en el colon sigmoides. La mucosa alrededor de estas saculaciones es de aspecto completamente normal, sin eritema ni sangrado activo.

Pregunta 1

De acuerdo con la descripción endoscópica de los hallazgos en un paciente asintomático, ¿cuál es el diagnóstico correcto?

A) Diverticulitis aguda no complicada

B) Enfermedad de Crohn colónica

C) Diverticulosis colónica *

D) Pólipos adenomatosos sésiles

Retroalimentación:

La presencia anatómica de divertículos (saculaciones formadas por la herniación de la mucosa y submucosa) en el colon de un paciente sin ningún síntoma inflamatorio o de sangrado se define estrictamente como diverticulosis.

Pregunta 2

Al tratarse de un hallazgo incidental sin inflamación ni complicación, ¿cuál es la recomendación terapéutica principal de acuerdo con la GPC?

A) Resección del colon sigmoides de manera electiva

B) Antibioticoterapia con Ciprofloxacino y Metronidazol por 7 días

C) Dieta rica en fibra y aumento en la ingesta de líquidos *

D) Mesalazina vía oral de por vida

Retroalimentación:

La diverticulosis asintomática no requiere tratamiento médico farmacológico ni quirúrgico invasivo. La GPC recomienda únicamente medidas higiénico-dietéticas, principalmente el aumento en el consumo de fibra dietética y agua para disminuir la presión intraluminal colónica y prevenir la progresión a enfermedad sintomática o diverticulitis.

Tema: Patología Hepática

Subtema: Enfermedad Hepática Grasa

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 48 años, con antecedente de obesidad grado II (IMC 36), diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia mixta. Acude a consulta por fatiga leve. En sus exámenes de laboratorio de rutina se detecta una elevación leve de transaminasas (ALT 65 U/L, AST 45 U/L), con fosfatasa alcalina y bilirrubinas normales. Niega consumo de alcohol y su panel viral para hepatitis B y C resulta negativo. Se le solicita un ultrasonido abdominal que reporta hígado aumentado de tamaño con un incremento difuso de la ecogenicidad ("hígado brillante"), atenuación del sonido posterior y pérdida de la definición de los vasos portales.

Pregunta 1

De acuerdo con los hallazgos clínicos y ecográficos, en ausencia de consumo de alcohol, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cirrosis hepática biliar primaria

B) Enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) *

C) Hepatitis autoinmune tipo 1

D) Hemocromatosis hereditaria

Retroalimentación:

La Enfermedad Hepática Grasa no Alcohólica (asociada a disfunción metabólica) está estrechamente ligada al síndrome metabólico (obesidad, diabetes, dislipidemia). El hallazgo ecográfico clásico es un hígado hiperecogénico ("brillante") provocado por la infiltración macrovesicular de triglicéridos.

Pregunta 2

Para estadificar el grado de fibrosis hepática de forma no invasiva antes de considerar una biopsia, ¿cuál es el estudio de imagen basado en la elasticidad del tejido que recomienda la GPC?

A) Elastografía de transición (FibroScan) *

B) Tomografía computarizada simple

C) Gammagrafía hepatoesplénica

D) ColangioRM

Retroalimentación:

La Elastografía de transición es la herramienta no invasiva de primera línea recomendada para medir la rigidez hepática y estimar de manera muy confiable el grado de fibrosis en pacientes con EHGNA o hepatitis crónicas, evitando así biopsias innecesarias.

Tema: ETS

Subtema: Linfogranuloma Venéreo

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 30 años de edad acude a consulta de infectología refiriendo la aparición de un aumento de volumen muy doloroso en la ingle derecha de 2 semanas de evolución. Al interrogatorio dirigido, menciona que hace aproximadamente 3 semanas notó una pequeña úlcera genital indolora que desapareció sola en un par de días, a la cual no le dio importancia. A la exploración física, presenta una gran

linfadenopatía inguinal y femoral derecha, la cual está separada por el ligamento inguinal creando el clásico "signo del surco". Los ganglios están eritematosos, fijos, muy sensibles y algunos presentan áreas de fluctuación (bubones).

Pregunta 1

De acuerdo con la clínica y el característico "signo del surco", ¿cuál es el diagnóstico infeccioso de sospecha?

A) Sífilis primaria

B) Chancroide

C) Linfogranuloma venéreo (LGV) *

D) Granuloma inguinal (Donovanosis)

Retroalimentación:

El Linfogranuloma venéreo comienza típicamente con una pápula o úlcera genital pequeña, transitoria e indolora (fase primaria), seguida semanas después por un síndrome inguinal invasivo (fase secundaria) caracterizado por adenopatías dolorosas supurativas. El "signo del surco" (adenopatías por arriba y por debajo del ligamento inguinal) es patognomónico del LGV.

Pregunta 2

¿Cuál es el microorganismo etiológico responsable de esta enfermedad de transmisión sexual?

A) Chlamydia trachomatis (serotipos L1, L2, L3) *

B) Klebsiella granulomatis

C) Haemophilus ducreyi

D) Treponema pallidum

Retroalimentación:

El LGV es causado exclusivamente por los serotipos invasivos L1, L2 y L3 de Chlamydia trachomatis, los cuales tienen un especial tropismo por el tejido linfático.

Pregunta 3

¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección y la duración recomendada por las guías clínicas para resolver esta patología?

A) Penicilina G benzatínica dosis única

B) Ceftriaxona 500 mg IM dosis única

C) Doxiciclina 100 mg VO cada 12 horas por 21 días *

D) Azitromicina 1 g VO dosis única

Retroalimentación:

El tratamiento de elección para el Linfogranuloma venéreo es la Doxiciclina. A diferencia del tratamiento para una uretritis simple por Chlamydia (que dura 7 días), el LGV requiere un tratamiento prolongado de 21 días para erradicar la infección profunda en los ganglios linfáticos y prevenir secuelas fibróticas graves.

Tema: Introducción Oftalmología

Subtema: Blefaritis

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 65 años de edad acude a consulta oftalmológica por referir ardor crónico, sensación de arenilla y prurito en ambos ojos de meses de evolución, que empeora por las mañanas. A la exploración en la lámpara de hendidura, los ojos presentan hiperemia conjuntival leve. Llama la atención que los bordes libres de ambos párpados se encuentran eritematosos y engrosados, observándose múltiples escamas amarillentas en la base de las pestañas (costras similares a la caspa). No hay nódulos ni tumefacciones agudas localizadas.

Pregunta 1

De acuerdo con la clínica, ¿cuál es el tratamiento higiénico inicial de primera línea indispensable para el control de esta enfermedad ocular crónica?

A) Inyección intralesional de triamcinolona

B) Aseo diario del borde palpebral con champú de bebé o espumas limpiadoras específicas y compresas tibias *

C) Antibióticos tópicos de amplio espectro de por vida

D) Depilación quirúrgica de las pestañas

Retroalimentación:

La blefaritis es una inflamación crónica del margen palpebral (anterior o posterior). La piedra angular del tratamiento, independientemente de la causa (estafilocócica o seborreica), es la higiene palpebral estricta y diaria: aplicación de compresas tibias para fluidificar las secreciones y lavado mecánico suave de la base de las pestañas con soluciones diluidas (como champú de bebé) para remover las costras y escamas adheridas.

Tema: PATOLOGÍA GÁSTRICA Subtema: GASTRITIS AGUDA O CRONICA

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 60 años, con antecedente de osteoartritis severa en tratamiento crónico con diclofenaco e ibuprofeno a dosis altas desde hace 1 año. Acude a la consulta externa por presentar dolor en epigastrio de tipo ardoroso, náuseas ocasionales y saciedad temprana. Se le realiza una endoscopia superior que reporta eritema difuso y múltiples erosiones superficiales en la mucosa del antro y cuerpo gástrico, sin úlceras activas.

Pregunta 1

Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cuál es el mecanismo principal por el cual el consumo crónico de estos fármacos (AINEs) produce el daño a la mucosa gástrica evidenciado en la paciente?

A) Estimulación directa de las células parietales para secretar ácido clorhídrico

B) Inhibición de la enzima ciclooxigenasa-1 (COX-1), lo que disminuye la síntesis de prostaglandinas protectoras *

C) Inhibición de la bomba de protones a nivel apical

D) Infección secundaria por Helicobacter pylori

Retroalimentación:

Los AINEs no selectivos inhiben tanto la COX-2 (disminuyendo la inflamación y el dolor) como la COX-1. La COX-1 es una enzima constitutiva en la mucosa gástrica responsable de sintetizar prostaglandinas (PGE2 y PGI2), las cuales son vitales para

mantener la barrera protectora gástrica al estimular la secreción de moco y bicarbonato, y mantener un adecuado flujo sanguíneo mucoso. Su inhibición deja a la mucosa vulnerable al daño por el ácido gástrico.

Tema: PATOLOGÍA HEPÁTICA Subtema: HEPATITIS AGUDAS Y CRÓNICAS

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 28 años, usuario de drogas intravenosas, acude a urgencias por presentar un cuadro de 1 semana de evolución caracterizado por astenia profunda, adinamia, mialgias, náuseas, dolor sordo en el hipocondrio derecho y coluria. A la exploración física destaca ictericia franca en escleras y piel, con hepatomegalia dolorosa a la palpación. Sus laboratorios revelan AST de 1,200 U/L y ALT de 1,500 U/L, con bilirrubina total de 8.0 mg/dL a expensas de la directa. Se solicita un panel serológico viral que reporta: HBsAg (+), Anti-HBc IgM (+), Anti-HBs (-).

Pregunta 1

De acuerdo con el panel serológico presentado, ¿cuál es el diagnóstico preciso del paciente?

A) Infección crónica por Virus de la Hepatitis B

B) Infección aguda por Virus de la Hepatitis B *

C) Paciente vacunado e inmunizado contra Hepatitis B

D) Hepatitis B resuelta con inmunidad natural

Retroalimentación:

La presencia del Antígeno de superficie (HBsAg) indica infección activa. El marcador clave para diferenciar una infección aguda de una crónica es el Anticuerpo contra el antígeno del core (Anti-HBc). Si es de tipo IgM, indica una infección aguda reciente (como en este caso). Si fuera IgG con HBsAg (+), indicaría infección crónica por más de 6 meses.

Pregunta 2

Durante esta fase aguda, ¿cuál es el marcador serológico específico que el médico debe solicitar para determinar si el paciente se encuentra en un estado de alta replicación viral y alta infectividad?

A) Anti-HBe

B) Antígeno e de la hepatitis B (HBeAg) *

C) Anti-HCV

D) DNA polimerasa

Retroalimentación:

El Antígeno e de la hepatitis B (HBeAg) es un péptido secretorio que se libera durante la replicación viral activa. Su positividad en el suero es un indicador directo de que el virus se está replicando activamente y, por lo tanto, el paciente tiene un riesgo extremadamente alto de transmitir la infección a otras personas.

Tema: PATOLOGÍA PERIANAL Subtema: FISTULAS

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 45 años, con antecedente de un absceso perianal drenado quirúrgicamente hace 8 meses. Acude a consulta refiriendo que, desde la cirugía, nota la salida intermitente de material seropurulento y fecaloideo a través de un pequeño orificio en la piel cercana al ano, lo cual le causa prurito y mancha su ropa interior. A la exploración física en posición de navaja sevillana, se observa un orificio fistuloso secundario (externo) localizado en el radio de las 4 del reloj (cuadrante posterior derecho), a 2 cm del margen anal.

Pregunta 1

Para planear la exploración quirúrgica, el cirujano utiliza una regla anatómica clásica que ayuda a predecir el trayecto de la fístula y la localización de su orificio primario (interno) basándose en la ubicación del orificio externo. ¿Cómo se llama esta regla?

A) Regla de Parkland

B) Criterios de Tokio

C) Regla de Goodsall *

D) Escala de Hinchey

Retroalimentación:

La regla de Goodsall establece que si se traza una línea transversal imaginaria a través del centro del ano: los orificios fistulosos externos situados anteriormente a esta línea tendrán un trayecto recto y corto hacia la cripta anal correspondiente (orificio interno). Por el contrario, los orificios externos situados posteriormente (como en este paciente, a las 4 del reloj) tendrán un trayecto curvo y largo que desembocará invariablemente en la línea media posterior del canal anal. Hay excepciones para fístulas anteriores a más de 3 cm del margen.

Tema: ATLS P1 Subtema: TRAUMA TORÁCICO (NEUMOTÓRAX ABIERTO)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 30 años es atendido por paramédicos en la vía pública tras sufrir una agresión con un machete. Presenta una herida abierta de aproximadamente 5 cm de diámetro en la pared torácica lateral derecha (cuarto espacio intercostal). A la evaluación primaria (A, B, C), el paciente se encuentra con severa dificultad respiratoria, taquipneico (35 rpm) y cianótico. Durante la inspiración, los paramédicos escuchan un sonido de succión característico proveniente de la herida, y observan que sale sangre burbujeante durante la espiración.

Pregunta 1

De acuerdo con la fisiopatología del trauma torácico, para que ocurra este fenómeno de "succión" y el aire prefiera entrar por la herida en lugar de por la tráquea (creando un neumotórax abierto), ¿qué tamaño mínimo debe tener la herida en la pared torácica?

A) Mayor al diámetro de la arteria aorta

B) Aproximadamente un tercio (1/3) del diámetro de la tráquea

C) Aproximadamente dos tercios (2/3) del diámetro de la tráquea del paciente *

D) El tamaño de la herida es irrelevante

Retroalimentación:

El ATLS establece que el aire siempre sigue el camino de menor resistencia. Si la herida en la pared torácica tiene un tamaño de aproximadamente dos tercios (2/3) o más del diámetro de la tráquea, el aire entrará preferentemente a través del defecto de la pared torácica durante la inspiración (por la presión negativa intratorácica), igualando las presiones y colapsando el pulmón afectado.

Pregunta 2

¿Cuál es la medida inicial, rápida y salvadora que deben aplicar los paramédicos en la escena del trauma para estabilizar la ventilación del paciente antes de trasladarlo?

A) Intubación orotraqueal inmediata en el lugar de los hechos

B) Colocación de un parche oclusivo estéril fijado con cinta adhesiva en tres de sus cuatro lados *

C) Cierre hermético de la herida suturando la piel en la ambulancia

D) Colocación de una gasa seca sin fijar

Retroalimentación:

El tratamiento inicial prehospitalario para un neumotórax abierto es sellar rápidamente el defecto con un apósito oclusivo (parche) fijado solo en tres de sus cuatro lados. Esto crea un efecto de válvula unidireccional: durante la inspiración, el parche se adhiere y sella la herida impidiendo que entre más aire; durante la espiración, el lado no fijado permite que el aire acumulado en la pleura escape, previniendo así la conversión letal hacia un neumotórax a tensión.

Pregunta 3

Una vez que el paciente llega a la sala de choque del hospital, ¿cuál es el manejo terapéutico definitivo indicado para esta patología?

A) Colocación de una sonda endopleural (tubo de tórax) y cierre quirúrgico del defecto de la pared *

B) Mantener el parche de tres lados hasta que la herida granule por segunda intención

C) Toracotomía de reanimación urgente

D) Pericardiocentesis

Retroalimentación:

El tratamiento definitivo intrahospitalario del neumotórax abierto requiere la colocación de un tubo de tórax (sonda endopleural) en un sitio distinto a la herida original para reexpandir el pulmón y drenar el aire/sangre, seguido del desbridamiento y cierre quirúrgico del defecto traumático de la pared torácica.

Tema: ATLS P2 Subtema: TCE HEMORRAGIA SUBDURAL

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 78 años de edad, con antecedente de alcoholismo crónico y atrofia cortical documentada, es traído a urgencias por su hija. Ella refiere que en las últimas 3 semanas ha notado a su padre con alteraciones en el comportamiento, lentitud mental, cefalea matutina leve y una progresiva debilidad en el hemicuerpo izquierdo. Menciona que hace aproximadamente un mes, el paciente sufrió una caída desde su propia altura golpeándose la cabeza, pero no perdió el conocimiento ni acudieron a revisión médica en su momento. A la exploración, Glasgow 13 (confusión leve), con hemiparesia izquierda 4/5.

Pregunta 1

Por la evolución insidiosa (semanas) y los antecedentes de edad avanzada y atrofia cerebral, la sospecha es un hematoma subdural crónico. Desde el punto de vista anatómico, ¿cuál es el vaso sanguíneo cuya ruptura condiciona más frecuentemente esta acumulación de sangre entre la duramadre y la aracnoides?

A) Arteria meníngea media

B) Seno sagital superior

C) Venas puente corticales *

D) Polígono de Willis

Retroalimentación:

El hematoma subdural es causado típicamente por el desgarro de las "venas puente" corticales que drenan desde la superficie del cerebro hacia los senos durales. En pacientes ancianos o alcohólicos, la atrofia cerebral hace que el cerebro se retraiga,

estirando estas venas y haciéndolas extremadamente susceptibles a romperse incluso con traumatismos menores o fuerzas de aceleración/desaceleración leves.

Pregunta 2

Se solicita una Tomografía Computarizada (TAC) de cráneo simple para confirmar el diagnóstico. ¿Cuál es la descripción radiológica clásica esperada para esta lesión en un estadio crónico?

A) Colección biconvexa hiperdensa que no cruza suturas

B) Sangre distribuida en los surcos y cisternas de la base

C) Colección en forma de semiluna o cóncavo-convexa, de densidad isodensa o hipodensa respecto al parénquima cerebral, que cruza suturas craneales *

D) Imagen en "sal y pimienta" dentro del parénquima

Retroalimentación:

La imagen tomográfica clásica del hematoma subdural es una colección hemática en forma de semiluna (cóncavo-convexa) que sigue el contorno del cerebro y es capaz de cruzar las suturas craneales (a diferencia del epidural). En la fase aguda la sangre es hiperdensa (blanca), pero en la fase crónica (semanas después, como en este paciente), la sangre degradada se vuelve isodensa o hipodensa (gris oscura) en relación con el tejido cerebral subyacente.

Tema: ATLS P3

Subtema: ATLS EN LA EMBARAZADA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Femenina de 28 años, cursando con embarazo de 34 semanas de gestación por fecha de última menstruación. Es ingresada a la sala de choque tras sufrir un accidente automovilístico con impacto frontal a alta velocidad; ella viajaba como copiloto y sí portaba el cinturón de seguridad. A su ingreso, la paciente se encuentra obnubilada, pálida y diaforética. Sus signos vitales revelan TA 80/50 mmHg, FC 125 lpm y FR 26 rpm. A la exploración física, el abdomen se encuentra globoso por el útero grávido, con altura uterina de 32 cm. Se palpa el útero hipertónico (leñoso) y la paciente presenta un sangrado transvaginal oscuro, de moderada cantidad.

Pregunta 1

Debido al compromiso hemodinámico (choque), ¿cuál es la maniobra posicional básica e indispensable que debe realizarse inmediatamente en la sala de urgencias para mejorar el gasto cardíaco de la madre?

A) Colocar en posición de Trendelenburg (cabeza más baja que los pies)

B) Desplazamiento manual del útero hacia la izquierda o elevación del lado derecho de la tabla espinal unos 15 grados *

C) Colocar en decúbito lateral derecho estricto

D) Elevar ambas extremidades inferiores a 45 grados

Retroalimentación:

En el tercer trimestre, el útero grávido comprime fuertemente la vena cava inferior cuando la paciente está en decúbito supino, reduciendo el retorno venoso y el gasto cardíaco hasta en un 30% (síndrome de hipotensión supina). El ATLS indica que el útero debe desplazarse manualmente hacia la izquierda o se debe inclinar la tabla espinal hacia la izquierda para liberar la compresión de la cava y optimizar la reanimación hemodinámica.

Pregunta 2

Según los lineamientos del ATLS para trauma en el embarazo, ante la presencia de un binomio madre-feto comprometido, ¿hacia quién deben ir dirigidos los esfuerzos iniciales de reanimación primaria (A-B-C)?

A) Reanimación prioritaria de la madre, ya que la mejor reanimación fetal es una adecuada reanimación materna *

B) Extracción fetal inmediata por cesárea perimortem al minuto 1

C) Monitorización fetal continua como paso "A" del protocolo

D) Reanimación simultánea priorizando los líquidos para el feto

Retroalimentación:

El principio fundamental del ATLS en la embarazada es que "la madre es primero". La supervivencia del feto depende íntegramente de la estabilidad hemodinámica y oxigenación materna. Por lo tanto, el protocolo ABCDE inicial se aplica a la madre de forma idéntica a un paciente no embarazado, priorizando su volumen circulante y oxigenación.

Pregunta 3

Por la cinemática del trauma (desaceleración brusca) y los hallazgos a la exploración (útero hipertónico y sangrado oscuro), ¿cuál es la complicación obstétrica traumática más probable que amenaza la vida del feto en este momento?

A) Ruptura uterina

B) Placenta previa

C) Desprendimiento prematuro de placenta normoincerta (DPPNI) *

D) Vasa previa

Retroalimentación:

El trauma cerrado de abdomen, especialmente con el mecanismo de cizallamiento provocado por el cinturón de seguridad durante una desaceleración rápida, es una causa clásica de Desprendimiento Prematuro de Placenta (DPPNI). La clínica patognomónica incluye hipertonía uterina, dolor, sufrimiento fetal y sangrado transvaginal oscuro (aunque puede ser oculto).

Tema: PATOLOGÍA INTESTINAL QX

Subtema: VÓLVULO DE COLON Y CIEGO

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 45 años, sin antecedentes quirúrgicos, acude por presentar dolor abdominal de inicio brusco en el mesogastrio y la fosa ilíaca derecha, progresivo, que posteriormente se generaliza. Refiere imposibilidad para canalizar gases, náuseas y dos episodios de vómito biliar. A la exploración física, el abdomen está francamente distendido, timpánico. Llama la atención que la fosa ilíaca derecha se palpa vacía, y se palpa una masa renitente y dolorosa en el mesogastrio.

Pregunta 1

Se solicita una radiografía simple de abdomen en bipedestación y decúbito. Se observa una gran asa dilatada en forma de "embrión" o "coma" que se origina en la fosa ilíaca derecha y se dirige hacia el epigastrio o hipocondrio izquierdo, acompañada de un solo nivel hidroaéreo. Con base en la sospecha de vólvulo de ciego, ¿cuál es el tratamiento inicial de elección según la GPC?

A) Descompresión endoscópica (colonoscopia) urgente

B) Exploración quirúrgica inmediata (Hemicolectomía derecha o ileocecectomía) *

C) Colocación de sonda rectal gruesa y enemas evacuantes

D) Reducción hidrostática con bario

Retroalimentación:

A diferencia del vólvulo de sigmoides (cuyo tratamiento inicial de elección es la descompresión endoscópica), el vólvulo de ciego tiene un riesgo mucho mayor de isquemia y perforación, y su reducción endoscópica tiene una tasa de éxito muy baja (solo 15-20%). Por lo tanto, la GPC y los libros de cirugía establecen que el tratamiento del vólvulo cecal es siempre quirúrgico de urgencia, realizando generalmente una resección ileocecal o hemicolectomía derecha.

Pregunta 2

Desde el punto de vista del desarrollo embrionario, ¿cuál es la alteración anatómica predisponente necesaria para que ocurra la volvulación del ciego?

A) Presencia de un divertículo de Meckel largo

B) Falta de fijación del colon derecho y el ciego al retroperitoneo (fijación mesentérica incompleta) *

C) Megacolon congénito (Enfermedad de Hirschsprung)

D) Atresia ileal distal

Retroalimentación:

Para que el ciego se tuerza sobre su propio eje, requiere tener movilidad. Normalmente, el ciego y el colon ascendente están fijos al retroperitoneo. El vólvulo de ciego ocurre en pacientes que tienen un defecto de fijación peritoneal congénito (ciego móvil), lo que le permite rotar sobre el mesenterio ileocecal.

Shutterstock

Tema: MORDEDURAS Y PICADURAS

Subtema: LATRODECTISMO

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 32 años, campesino, acude a urgencias con intenso dolor generalizado de inicio súbito. Refiere haber sentido un pinchazo en el antebrazo derecho hace una hora mientras movía leña en un cuarto oscuro. A su llegada, el paciente se encuentra con diaforesis profusa, agitación psicomotriz, sialorrea, epífora y fasciculaciones. A la exploración abdominal, el abdomen se encuentra rígido, "en madera", simulando un abdomen agudo peritonítico. Sus signos vitales evidencian taquicardia (130 lpm) e hipertensión (160/100 mmHg).

Pregunta 1

Por el cuadro clínico de neurotoxicidad severa con predominio de espasmos musculares y rigidez abdominal (sin lesión dermo-necrótica local), ¿cuál es la toxina responsable liberada por el agente causal (Araña Viuda Negra / Latrodectus mactans)?

A) Esfingomielinasa D

B) Alfa-latrotoxina *

C) Escorpamina

D) Crotoxina

Retroalimentación:

La alfa-latrotoxina es el principal componente del veneno de la viuda negra. Se une a los receptores presinápticos en las placas neuromusculares, provocando una exocitosis masiva e incontrolable de neurotransmisores (especialmente acetilcolina y norepinefrina). Esto genera el cuadro de latrodectismo: espasmos musculares dolorosos severos (típicamente rigidez abdominal que simula abdomen agudo quirúrgico), hiperactividad autonómica (diaforesis, taquicardia) y facies latrodectísmica. La esfingomielinasa D es la toxina de la araña violinista (Loxosceles).

Tema: INTRODUCCIÓN OFTALMOLOGÍA

Subtema: ORZUELO

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 18 años acude a consulta por referir la aparición de una "bolita" en el párpado inferior del ojo izquierdo, la cual inició hace 48 horas con enrojecimiento y dolor. A la exploración física oftalmológica, se observa un nódulo eritematoso, focal y exquisitamente doloroso a la palpación en el margen libre del párpado inferior, centrado alrededor de un folículo piloso de una pestaña, con un pequeño punto blanquecino de supuración apuntando hacia el exterior.

Pregunta 1

De acuerdo con la presentación clínica aguda, eritematosa y dolorosa, ¿cuál es el diagnóstico correcto y la glándula afectada?

A) Chalazión; inflamación crónica estéril de las glándulas de Meibomio

B) Orzuelo externo; infección bacteriana aguda de las glándulas de Zeis o Moll *

C) Orzuelo interno; infección aguda de la glándula lagrimal

D) Dacriocistitis; infección del saco lagrimal

Retroalimentación:

El orzuelo externo es un absceso estafilocócico agudo, eritematoso y doloroso localizado en el margen palpebral, originado por la infección de los folículos de las pestañas y sus glándulas sebáceas accesorias asociadas (Zeis o Moll). El chalazión, por el contrario, es una lesión nodular crónica, firme y típicamente indolora, producida por la inflamación granulomatosa no infecciosa de una glándula de Meibomio en el tarso.

Tema: PATOLOGÍA ISQUÉMICA INTESTINAL

Subtema: ISQUEMIA MESENTERICA AGUDA Y CRÓNICA

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 68 años de edad, con antecedente de tabaquismo de 40 paquetes/año y enfermedad arterial periférica severa. Acude a la consulta de gastroenterología por pérdida de peso progresiva (12 kg en los últimos 6 meses) y dolor abdominal crónico.

El paciente describe el dolor como un dolor cólico sordo en el mesogastrio que inicia de forma invariable 30 a 45 minutos después de ingerir cualquier alimento, y que cede lentamente al cabo de un par de horas. Debido a esto, el paciente refiere tener "miedo a comer" (sitofobia) y ha reducido drásticamente el tamaño de sus porciones.

Pregunta 1

Con base en los antecedentes ateroscleróticos y el patrón clínico clásico de dolor postprandial con sitofobia, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A) Úlcera péptica gástrica

B) Isquemia mesentérica aguda

C) Isquemia mesentérica crónica (Angina intestinal) *

D) Cáncer de cabeza de páncreas

Retroalimentación:

La isquemia mesentérica crónica, también conocida como "angina intestinal", se presenta en pacientes con ateroesclerosis sistémica severa. Su tríada clásica (aunque rara vez completa) es: dolor abdominal postprandial (causado por la incapacidad de las arterias ocluidas de aumentar el flujo sanguíneo requerido para la digestión), pérdida de peso progresiva y sitofobia (miedo a alimentarse por el dolor anticipado).

Pregunta 2

Para confirmar el diagnóstico y planear una posible revascularización quirúrgica o endovascular, ¿cuál es el estudio de imagen estándar de oro para documentar la estenosis de los vasos esplácnicos (tronco celíaco y arterias mesentéricas)?

A) Endoscopia superior con toma de biopsia

B) Arteriografía mesentérica o Angiotomografía (AngioTAC) abdominal *

C) Serie esofagogastroduodenal

D) Ultrasonido pélvico

Retroalimentación:

El estándar de oro histórico para diagnosticar la oclusión o estenosis de los vasos mesentéricos es la arteriografía convencional, aunque actualmente la AngioTAC abdominal ha reemplazado a la arteriografía como el estudio de imagen inicial de

elección por ser menos invasiva, permitiendo reconstrucciones 3D de alta calidad del tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior (se requiere afectación de al menos 2 de estos vasos para presentar síntomas crónicos debido a la rica red colateral).

Tema: INTRODUCCIÓN A CIRUGÍA Y CIRUGÍA ABDOMINAL

Subtema: ABDOMEN AGUDO

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 45 años, sin antecedentes crónicos de importancia, acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal de inicio súbito y muy intenso, de 4 horas de evolución. Refiere que el dolor se exacerba con el más mínimo movimiento, incluso al toser o respirar profundamente. A la exploración física, el paciente se encuentra inmóvil en decúbito supino, diaforético y taquicárdico. El abdomen se encuentra plano, sin ruidos peristálticos, y presenta una rigidez muscular involuntaria generalizada ("abdomen en tabla"). Se elicita dolor intenso a la descompresión rápida de la pared abdominal en cualquier cuadrante.

Pregunta 1

El hallazgo exploratorio de dolor intenso a la descompresión rápida de la pared abdominal es un signo clínico inequívoco de irritación peritoneal generalizada. ¿Qué nombre recibe este signo semiológico clásico?

A) Signo de Murphy

B) Signo de Rovsing

C) Signo de Blumberg (Rebote) *

D) Signo de Courvoisier

Retroalimentación:

El signo de Blumberg, comúnmente conocido como signo del rebote, se define como la exacerbación del dolor abdominal tras la palpación profunda seguida de una liberación (descompresión) brusca de la mano del examinador. Es el signo clínico cardinal de la inflamación del peritoneo parietal (peritonitis localizada o generalizada) que exige evaluación quirúrgica.Tema: CIRROSIS Y SUS COMPLICACIONES / TRASPLANTE HEPATICO

Subtema: ASCITIS

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Femenina de 60 años, con diagnóstico de cirrosis hepática secundaria a esteatohepatitis no alcohólica (NASH), acude a consulta externa por referir un aumento progresivo del perímetro abdominal en el último mes, acompañado de ganancia de peso y edema en extremidades inferiores. Niega disnea, fiebre, dolor abdominal o alteraciones en el estado de alerta. A la exploración física, el abdomen se encuentra globoso, con matidez cambiante a la percusión y signo de la oleada ascítica positivo.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, tratándose del primer episodio clínico de ascitis en esta paciente, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico inicial e indispensable que se debe realizar en el consultorio o urgencias para establecer la etiología del líquido y descartar infecciones ocultas?

A) Ecografía Doppler de la vena porta

B) Paracentesis diagnóstica con extracción de 20-50 cc de líquido *

C) Tomografía computarizada de abdomen contrastada

D) Biopsia hepática percutánea

Retroalimentación:

La paracentesis diagnóstica es obligatoria en todo paciente con ascitis de inicio reciente (o en un paciente con ascitis crónica que ingresa al hospital o presenta deterioro clínico). Permite analizar el líquido (citoquímico y citológico) para confirmar la etiología y descartar una peritonitis bacteriana espontánea asintomática.

Pregunta 2

Al analizar el líquido extraído, ¿cuál es el parámetro bioquímico que confirma que la ascitis de la paciente es de origen hipertensivo portal (trasudado) y no debida a otras causas como carcinomatosis peritoneal o tuberculosis?

A) Proteínas totales en líquido ascítico < 2.5 g/dL

B) Conteo de leucocitos polimorfonucleares > 250 células/mm^3

C) Gradiente de Albúmina Suero-Ascitis (GASA) ≥ 1.1 g/dL *

D) Glucosa en líquido ascítico < 50 mg/dL

Retroalimentación:

El Gradiente de Albúmina Suero-Ascitis (GASA), que se calcula restando la albúmina del líquido ascítico a la albúmina sérica tomada el mismo día, es el método más preciso. Un GASA ≥ 1.1 g/dL indica con un 97% de precisión que la ascitis es causada por hipertensión portal (como en la cirrosis). Un GASA < 1.1 g/dL sugiere causas no relacionadas con hipertensión portal (exudados por cáncer, inflamación, etc.).

Pregunta 3

Confirmado el origen cirrótico no complicado de la ascitis, además de la restricción de sodio en la dieta, ¿cuál es el régimen diurético de primera elección recomendado para iniciar el manejo de la ascitis moderada?

A) Furosemida en monoterapia a dosis altas

B) Espironolactona en monoterapia o combinada con Furosemida (proporción 100 mg / 40 mg) *

C) Hidroclorotiazida exclusivamente

D) Manitol intravenoso

Retroalimentación:

La GPC y las guías hepatológicas recomiendan iniciar con Espironolactona (un antagonista de la aldosterona, ya que los cirróticos tienen hiperaldosteronismo secundario marcado) sola, o en combinación inicial con Furosemida en una proporción estricta de 100 mg a 40 mg para mantener la normopotasemia y lograr una pérdida de peso controlada.Tema: PATOLOGÍA CÁMARA ANTERIORSubtema: EPIESCLERITISDificultad: BajaCaso clínico (Corto):Femenina de 35 años, previamente sana, acude a la consulta oftalmológica por presentar enrojecimiento localizado en la región temporal del ojo derecho de 2 días de evolución. Refiere molestia ocular leve ("como si trajera una basurita"), pero niega dolor profundo, fotofobia, lagrimeo o disminución de la agudeza visual. A la inspección, se observa una congestión vascular superficial, localizada y de color rojo brillante en la esclera temporal derecha. El médico aplica una gota de fenilefrina al 10% (agente vasoconstrictor) en el fondo de saco, notando que el enrojecimiento vascular palidece casi por completo (blanqueamiento del área hiperémica) a los pocos minutos.Pregunta 1

Con base en la clínica leve y la prueba de fenilefrina positiva, ¿cuál es el diagnóstico correcto que distingue este cuadro de inflamaciones oculares más graves?

A) Escleritis nodular

B) Epiescleritis *

C) Uveítis anterior

D) Glaucoma agudo

Retroalimentación:

La epiescleritis es una inflamación aguda, benigna y a menudo autolimitada del tejido epiescleral superficial. Cursa con molestia leve y enrojecimiento (sectorial o difuso) brillante. La prueba de oro clínica diferencial es la aplicación de fenilefrina tópica: al ser vasos superficiales los afectados en la epiescleritis, estos se contraen y la zona palidece (blanquea). En la escleritis (una entidad destructiva profunda mucho más grave), los vasos del plexo profundo están ingurgitados y no blanquean con la fenilefrina.Tema: TRAUMA GENERALIDADES Y COMPLICACIONES

Subtema: SX DE DOLOR LOCOREGIONAL

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 52 años, quien sufrió una fractura de Colles (radio distal) en la muñeca derecha hace 8 semanas, tratada de forma conservadora con inmovilización prolongada con yeso. Actualmente la fractura se encuentra consolidada y el yeso fue retirado. Sin embargo, la paciente acude a consulta quejándose de un dolor ardoroso insoportable, continuo y desproporcionado en toda la mano derecha, que se desencadena incluso con el simple roce de la ropa (alodinia). A la exploración física, la mano derecha se observa edematizada, eritematosa, sudorosa, con temperatura aumentada en comparación con la contralateral. Los dedos están rígidos y la piel se nota lustrosa y atrófica.

Pregunta 1

De acuerdo con los Criterios de Budapest y la presentación clínica (dolor desproporcionado tras un trauma menor o inmovilización, asociado a cambios autonómicos, vasomotores y tróficos), ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome compartimental crónico

B) Osteomielitis aguda

C) Síndrome de Dolor Regional Complejo (Síndrome de Sudeck) *

D) Neuropatía diabética periférica

Retroalimentación:

El Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC), anteriormente conocido como Distrofia Simpático Refleja o Síndrome de Sudeck, es una complicación neuroinflamatoria aberrante que ocurre típicamente tras un traumatismo en una extremidad (como una fractura de muñeca). Se caracteriza por dolor neuropático extremo y desproporcionado (hiperalgesia, alodinia), acompañado de disregulación autonómica que produce edema, cambios en el color de la piel, sudoración asimétrica y alteraciones tróficas (piel brillante, pérdida de vello, rigidez articular).

Pregunta 2

Según las guías de práctica clínica para el tratamiento multimodal de esta patología, además de la fisioterapia y rehabilitación tempranas y agresivas, ¿cuál de los siguientes grupos farmacológicos se utiliza como piedra angular para el manejo del dolor neuropático?

A) AINEs a dosis plenas

B) Gabapentinoides (Gabapentina o Pregabalina) *

C) Corticosteroides intramusculares mensuales

D) Relajantes musculares (Metocarbamol)

Retroalimentación:

El dolor en el SDRC tiene un origen neuropático y mediado por el sistema nervioso central y simpático. Los neuromoduladores como los gabapentinoides (Pregabalina, Gabapentina), solos o en combinación con antidepresivos tricíclicos (Amitriptilina), son los fármacos de primera línea para modular la hiperexcitabilidad nerviosa y controlar la alodinia, permitiendo así que el paciente tolere la terapia física (que es el tratamiento definitivo para evitar la atrofia permanente).Tema: INTRODUCCIÓN OFTALMOLOGÍASubtema: DACRIOADENITISDificultad: BajaCaso clínico (Corto):Preescolar masculino de 6 años es llevado a la consulta de oftalmología pediátrica por presentar un cuadro de inicio agudo caracterizado por dolor, fiebre y un aumento de volumen importante en el tercio externo del párpado superior derecho. A la exploración física, se observa un eritema marcado y tumefacción en la región

superotemporal de la órbita derecha, lo que provoca que el párpado superior adquiera una deformidad característica en forma de "S" itálica.Pregunta 1

Dada la localización superotemporal de la inflamación y la clásica deformidad palpebral descrita, ¿cuál de las siguientes estructuras anatómicas está primariamente infectada o inflamada (Dacrioadenitis)?

A) Saco lagrimal

B) Glándulas de Meibomio

C) Glándula lagrimal principal *

D) Conducto nasolagrimal

Retroalimentación:

La dacrioadenitis es la inflamación de la glándula lagrimal principal, la cual se localiza anatómicamente en la fosa lagrimal (cuadrante orbitario superotemporal). Su inflamación aguda produce un agrandamiento que empuja el párpado superior hacia abajo y adentro, originando la característica deformidad en "S" itálica del borde palpebral. Esto la diferencia claramente de la dacriocistitis (infección del saco lagrimal), la cual se localiza en la porción inferomedial (cerca del canto interno o nariz) del ojo.

Tema: HERNIAS / ESPLENECTOMÍA

Subtema: Hernias

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Lactante masculino de 10 meses de edad es llevado a la consulta de control del niño sano. La madre refiere preocupación porque nota una "bolita" en el ombligo del bebé que protruye más cuando llora o hace esfuerzo para evacuar, pero que desaparece cuando está dormido. A la exploración física, el paciente se encuentra tranquilo, asintomático. A nivel de la cicatriz umbilical se palpa un anillo herniario de aproximadamente 1.2 cm de diámetro, a través del cual protruye una masa blanda, indolora y fácilmente reductible.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC para hernias de la pared abdominal en la edad pediátrica, ¿cuál es la indicación terapéutica correcta en este momento para el paciente?

A) Programar para plastía umbilical (herniorrafia) de manera electiva en el próximo mes

B) Colocación de fajas, monedas o vendajes compresivos umbilicales

C) Observación y manejo conservador, ya que la mayoría cierra espontáneamente antes de los 2 a 4 años de edad *

D) Referencia urgente a cirugía pediátrica para colocación de malla

Retroalimentación:

La hernia umbilical en lactantes se debe al cierre incompleto del anillo umbilical. La GPC establece que el manejo inicial es la observación, ya que más del 80-90% de los defectos menores a 1.5 cm cerrarán espontáneamente antes de los 2 a 4 años de edad. El tratamiento quirúrgico se indica si el defecto es mayor a 1.5 cm, si persiste después de los 4 años o si presenta alguna complicación (encarcelamiento), lo cual es extremadamente raro en hernias umbilicales pediátricas. Las fajas o monedas están contraindicadas.

Tema: QUEMADURAS / GOLPE DE CALOR / HIPOTERMIA

Subtema: Hipotermia

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 45 años es rescatado por protección civil tras haberse perdido durante una excursión en la montaña y pasar la noche a la intemperie bajo una nevada severa. A su ingreso a urgencias, el paciente se encuentra letárgico, no presenta escalofríos (shivering abolido), tiene midriasis y bradicardia severa. La medición de su temperatura corporal central con termómetro esofágico marca 29°C.

Getty Images

Pregunta 1

Dada la temperatura central del paciente (29°C), se clasifica como hipotermia moderada-severa. Al realizarle un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿cuál es el hallazgo patognomónico clásico esperado en esta patología térmica?

A) Inversión profunda de las ondas T en derivaciones precordiales

B) Elevación cóncava difusa del segmento ST

C) Deflexión positiva tardía en la unión del complejo QRS y el segmento ST (Onda J de Osborn) *

D) Acortamiento extremo del intervalo QT

Retroalimentación:

La Onda J de Osborn es una deflexión positiva adicional que aparece al final del complejo QRS y el inicio del segmento ST. Es un hallazgo electrocardiográfico clásico y patognomónico de la hipotermia sistémica, y su amplitud suele ser directamente proporcional al grado de descenso de la temperatura central.

Pregunta 2

Para el manejo del paciente (sin paro cardiorrespiratorio), ¿cuál es el método de recalentamiento primario de elección indicado por las guías de reanimación?

A) Recalentamiento pasivo externo exclusivo (quitar ropa mojada y poner mantas)

B) Recalentamiento activo externo (lámparas de calor y mantas térmicas eléctricas)

C) Recalentamiento activo interno (fluidos intravenosos cristaloides calentados a 39-40°C y oxígeno húmedo caliente) *

D) Baño de inmersión en agua hirviendo a 45°C

Retroalimentación:

En la hipotermia moderada a severa (temperatura central < 30°C) con abolición del escalofrío, el paciente ha perdido la capacidad de generar calor propio. El tratamiento de elección para estabilizar la temperatura del núcleo (corazón/cerebro) y evitar el fenómeno de "afterdrop" (caída adicional de la temperatura al vasodilatar la periferia) es el recalentamiento activo interno, siendo la infusión de cristaloides IV calentados y la ventilación con oxígeno caliente/humidificado las medidas iniciales más importantes.

Tema: PATOLOGÍA CÁMARA ANTERIOR

Subtema: Pinguécula

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 50 años, albañil de profesión, acude a la consulta externa de oftalmología por notar una pequeña "mancha amarillenta" en la parte blanca de ambos ojos que le preocupa desde hace varios meses. Refiere irritación y ojo rojo ocasional tras jornadas expuestas al sol y al polvo, pero niega disminución de la agudeza visual. A la exploración en lámpara de hendidura, se observa un pequeño nódulo o depósito amarillento, solevantado, localizado en la conjuntiva bulbar nasal de ambos ojos, cerca del limbo esclerocorneal.

Getty Images

Pregunta 1

Al realizar la inspección detallada, ¿cuál es el hallazgo clínico diferencial que permite confirmar que esta lesión es una pinguécula y NO un pterigión?

A) La lesión se asocia fuertemente a exposición solar

B) La lesión respeta el limbo y NO invade la córnea *

C) La lesión tiene una forma triangular con base periférica

D) La lesión causa astigmatismo irregular severo

Retroalimentación:

Tanto la pinguécula como el pterigión son degeneraciones fibrovasculares de la conjuntiva asociadas a la exposición crónica a los rayos UV, viento y polvo. La diferencia clínica fundamental es que la pinguécula es un nódulo amarillento que se mantiene exclusivamente en la conjuntiva bulbar y nunca cruza el limbo para invadir la córnea. El pterigión, en cambio, sí invade el tejido corneal. El tratamiento de la pinguécula es conservador con lubricantes.

Tema: PATOLOGÍA DE EXTREMIDAD SUPERIOR

Subtema: Fx de antebrazo y mano

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Masculino de 26 años sufre caída desde su propia altura mientras jugaba fútbol, recibiendo un golpe directo en la cara posterior del antebrazo derecho al intentar protegerse. Acude a urgencias con intenso dolor, incapacidad funcional y deformidad evidente en el tercio proximal del antebrazo. A la exploración física, presenta dolor intenso a la pronosupinación, y se nota limitación para la extensión de la muñeca y los dedos (mano levemente caída).

Pregunta 1

Se toman radiografías AP y lateral de antebrazo, las cuales evidencian una fractura de la diáfisis del cúbito en su tercio proximal. Basado en los epónimos traumatológicos clásicos, ¿cuál es la lesión articular que debe buscarse intencionadamente en las radiografías, ya que completa el cuadro de la "Fractura de Monteggia"?

A) Luxación de la articulación radiocubital distal

B) Luxación de la cabeza del radio (articulación radiocapitular) *

C) Fractura del radio distal concomitante

D) Fractura del escafoides carpiano

Retroalimentación:

La lesión de Monteggia es un complejo traumático definido clásicamente como la fractura de la diáfisis del cúbito (generalmente en el tercio proximal o medio) asociada a la luxación anterior de la cabeza del radio. La regla mnemotécnica "MUGR" (Monteggia: Ulna fx + G... / Galeazzi: Radius fx + radioulnar luxation) ayuda a recordarlo.

Pregunta 2

Dado el cuadro clínico de limitación para la extensión de la muñeca y los dedos, ¿cuál es el nervio que se lesiona con mayor frecuencia en esta fractura-luxación específica (Monteggia) debido a su estrecha relación anatómica con el cuello del radio?

A) Nervio mediano (rama interósea anterior)

B) Nervio cubital en el canal de Guyon

C) Nervio interóseo posterior (rama profunda motora del nervio radial) *

D) Nervio musculocutáneo

Retroalimentación:

La cabeza del radio al luxarse (típicamente hacia anterior) puede comprimir o estirar el nervio interóseo posterior, el cual es la rama motora profunda del nervio radial. Esta neuropraxia se manifiesta por debilidad o incapacidad para extender los dedos y el pulgar, y a veces la muñeca, sin afección de la sensibilidad (ya que es una rama puramente motora).

Pregunta 3

En un paciente adulto con esta lesión (Fractura de Monteggia), ¿cuál es el tratamiento ortopédico de elección?

A) Reducción cerrada y colocación de yeso braquipalmar por 8 semanas

B) Reducción abierta y fijación interna (RAFI) con placa y tornillos para el cúbito *

C) Escisión quirúrgica de la cabeza del radio exclusivamente

D) Colocación de fijadores externos temporales

Retroalimentación:

A diferencia de los niños (donde la reducción cerrada suele ser exitosa), la fractura de Monteggia en el adulto se considera una fractura altamente inestable. El "estándar de oro" es el tratamiento quirúrgico: Reducción Abierta y Fijación Interna (RAFI) anatómica y rígida del cúbito con placa y tornillos. Al restaurar perfectamente la longitud del cúbito, la cabeza del radio suele reducirse por sí sola de forma espontánea e indirecta.

Tema: HIPOACUSIA Y VÉRTIGO

Subtema: Hipoacusia neurosensorial

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 75 años, sin antecedentes de trauma acústico ni exposición a fármacos ototóxicos. Acude a la consulta llevado por sus familiares, quienes refieren que el paciente tiene dificultades progresivas para entender las conversaciones desde hace varios años, especialmente en reuniones familiares o restaurantes donde hay ruido de fondo ("oye pero no entiende"). A la exploración, la otoscopia de ambos oídos es completamente normal, sin tapones de cerumen y con membranas timpánicas íntegras.

Pregunta 1

Se le realiza una prueba de Rinne que resulta positiva bilateral (conducción aérea > conducción ósea), y la prueba de Weber no lateraliza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta entidad degenerativa?

A) Otoesclerosis

B) Enfermedad de Ménière

C) Presbiacusia *

D) Schwannoma vestibular (Neurinoma del acústico)

Retroalimentación:

La presbiacusia es la causa más común de hipoacusia en el adulto mayor. Es una hipoacusia neurosensorial bilateral, simétrica y progresiva, debida a la degeneración de las células ciliadas del órgano de Corti por el envejecimiento. Clásicamente, los pacientes conservan la audición para tonos graves (Rinne positivo, Weber central), pero pierden la discriminación del habla, especialmente en ambientes ruidosos.

Pregunta 2

Para confirmar el diagnóstico, se solicita una audiometría tonal pura. ¿Cuál es el patrón audiométrico patognomónico esperado para la presbiacusia?

A) Caída aislada de la vía ósea en la frecuencia de 2000 Hz (Escotoma de Carhart)

B) Hipoacusia de conducción en frecuencias graves (250 a 500 Hz)

C) Hipoacusia neurosensorial bilateral y simétrica con caída progresiva en las frecuencias agudas (4000 a 8000 Hz) *

D) Hipoacusia mixta unilateral

Retroalimentación:

El audiograma típico de la presbiacusia muestra una hipoacusia neurosensorial (vía aérea y vía ósea caen juntas sin "gap" u hoquedad) que es bilateral, simétrica y que afecta principalmente las frecuencias altas o agudas (descendente desde los 4000 hasta los 8000 Hz). Esta pérdida de agudos explica la incapacidad del paciente para discriminar las consonantes (que son de alta frecuencia), causando el síntoma clásico de "oír pero no entender".

Tema: PATOLOGÍA BILIAR

Subtema: COLECISTITIS AGUDA

Dificultad: Media

Caso clínico (Largo):

Femenina de 42 años, con obesidad grado I y multípara. Acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal en epigastrio e hipocondrio derecho de 12 horas de evolución, continuo, de intensidad 8/10, que inició tras la ingesta de alimentos ricos en grasas. Refiere náuseas, dos episodios de vómito de contenido biliar y sensación de alza térmica. A la exploración física: Temperatura 38.1°C, FC 98 lpm, TA 120/80 mmHg. El abdomen presenta hiperestesia y resistencia muscular localizada en el cuadrante superior derecho. Al realizar la palpación profunda por debajo del reborde costal derecho y pedirle a la paciente que realice una inspiración profunda, esta interrumpe súbitamente la respiración debido a un tope doloroso.

Pregunta 1

El cese abrupto de la inspiración profunda durante la palpación del hipocondrio derecho es el hallazgo clínico más característico de esta patología. ¿Qué nombre recibe este signo semiológico?

A) Signo de Courvoisier-Terrier

B) Signo de Rovsing

C) Signo de Murphy *

D) Signo de Cullen

Retroalimentación:

El signo de Murphy es altamente sensible y específico para la colecistitis aguda. Se produce cuando la vesícula biliar inflamada (que desciende durante la inspiración por la contracción del diafragma) choca contra los dedos del examinador, provocando un dolor tan agudo que obliga al paciente a detener la inspiración involuntariamente.

Pregunta 2

Según las guías de Tokio y la GPC, se le solicita un ultrasonido de hígado y vías biliares (estudio de imagen inicial de elección). ¿Cuál de los siguientes es un hallazgo ecográfico que confirma inflamación aguda de la vesícula biliar?

A) Pared vesicular con un grosor de 2 mm

B) Ausencia de sombra acústica posterior

C) Engrosamiento de la pared vesicular > 4 mm (o > 5 mm según algunas guías) y presencia de líquido perivesicular *

D) Conducto colédoco dilatado > 10 mm

Retroalimentación:

Los criterios ecográficos mayores de colecistitis aguda incluyen: engrosamiento de la pared vesicular (típicamente > 4-5 mm), edema de la pared (signo del doble riel), presencia de líquido perivesicular, distensión de la vesícula (hidrocolecisto > 8x4 cm) y un signo de Murphy ecográfico positivo al presionar con el transductor.

Pregunta 3

Confirmado el diagnóstico de colecistitis aguda grado I (leve, sin disfunción orgánica), ¿cuál es el estándar de oro terapéutico y el momento ideal para realizarlo según la GPC?

A) Colecistectomía laparoscópica temprana (idealmente en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas) *

B) Colecistectomía abierta de urgencia

C) Antibioticoterapia exclusiva por 14 días y cirugía electiva a los 6 meses

D) Drenaje percutáneo (colecistostomía)

Retroalimentación:

El tratamiento de elección para la colecistitis aguda no complicada es la colecistectomía laparoscópica temprana, definida como aquella que se realiza durante el mismo internamiento, idealmente dentro de las primeras 72 horas o la primera semana de iniciados los síntomas. Retrasar la cirugía ("enfriar el cuadro") aumenta los costos, los días de estancia y la morbilidad por adherencias crónicas.

Tema: PATOLOGÍA INTESTINAL QX

Subtema: APENDICITIS AGUDA

Dificultad: Baja

Caso clínico (Medio):

Masculino de 22 años, previamente sano, acude a urgencias quejándose de dolor abdominal de 18 horas de evolución. Refiere que el dolor comenzó de forma difusa alrededor del ombligo (periumbilical) pero hace 6 horas migró y se localizó de forma constante en la fosa ilíaca derecha. Presenta anorexia, náuseas y ha vomitado en una ocasión. A la exploración física: Temperatura 37.8°C. Abdomen plano, con dolor intenso a la palpación en el punto de McBurney y signo de rebote positivo localizado. Laboratorios: Leucocitos 13,000/mm^3 con 85% de neutrófilos.

Pregunta 1

De acuerdo con la Escala de Alvarado utilizada para estratificar el riesgo clínico de apendicitis aguda, ¿cuáles son los dos parámetros clínicos/laboratoriales que otorgan 2 puntos cada uno en esta escala?

A) Anorexia y náuseas

B) Fiebre y desviación a la izquierda (bandemia)

C) Dolor en fosa ilíaca derecha y leucocitosis *

D) Migración del dolor y signo de rebote

Retroalimentación:

La Escala de Alvarado (MANTRELS) tiene un puntaje máximo de 10. Todos los criterios valen 1 punto, EXCEPTO la leucocitosis (>10,000) y el dolor (tenderness) en el cuadrante inferior derecho, los cuales otorgan 2 puntos cada uno por ser los hallazgos más consistentes. Un puntaje ≥ 7 indica alta probabilidad de apendicitis aguda y justifica la exploración quirúrgica.

Pregunta 2

Al realizar la exploración física, el médico presiona profunda y firmemente la fosa ilíaca izquierda, lo que provoca que el paciente refiera un aumento del dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué nombre recibe este signo clínico?

A) Signo de Psoas

B) Signo de Obturador

C) Signo de Rovsing *

D) Signo de Dunphy

Retroalimentación:

El signo de Rovsing es positivo cuando la palpación de la fosa ilíaca izquierda produce dolor en la fosa ilíaca derecha. Esto ocurre porque al presionar el colon descendente, el gas intraluminal es desplazado de forma retrógrada hacia el ciego, distendiéndolo y estimulando el apéndice inflamado.

Tema: UROLOGÍA P2

Subtema: CÁNCER DE PRÓSTATA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 68 años acude a su chequeo médico anual. Se encuentra asintomático, sin datos de prostatismo (IPSS de 4 puntos). Como parte de su tamizaje, se le realiza la determinación de Antígeno Prostático Específico (APE), el cual se reporta en 8.5 ng/mL (marcadamente elevado para su edad). Se procede a realizar un tacto rectal, en el cual el médico palpa un nódulo pétreo, indurado e indoloro en el lóbulo derecho de la próstata.

Pregunta 1

Considerando que la gran mayoría (>95%) de las neoplasias malignas de este órgano son adenocarcinomas, ¿en qué zona anatómica de la glándula prostática se origina más del 70% de estos tumores, lo que explica por qué son frecuentemente palpables al tacto rectal y rara vez causan síntomas urinarios tempranos?

A) Zona de transición

B) Zona periférica *

C) Zona central

D) Estroma fibromuscular anterior

Retroalimentación:

El adenocarcinoma de próstata tiene una predilección absoluta (70-80%) por originarse en la zona periférica de la glándula (la parte más externa y posterior, que está en contacto íntimo con el recto). Al estar alejados de la uretra, crecen de forma silente sin causar síntomas obstructivos hasta etapas muy avanzadas. Por el contrario, la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) se origina casi siempre en la zona de transición (alrededor de la uretra), causando síntomas urinarios de forma temprana.

Tema: TRAUMA GENERALIDADES Y COMPLICACIONES

Subtema: SÍNDROME COMPARTIMENTAL

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 30 años, sufrió una fractura cerrada de la diáfisis tibial izquierda hace 24 horas mientras jugaba fútbol. Fue tratado inicialmente en otro centro con reducción cerrada y colocación de un yeso cruropédico circular. Acude a urgencias quejándose de un dolor insoportable en la pierna izquierda, el cual describe como "desgarrador" y que no cede con la administración de opioides intravenosos. A la exploración, los dedos del pie izquierdo están pálidos y parestésicos. El médico retira inmediatamente el yeso completo, notando la pierna brillante, a tensión extrema ("de madera"). Los pulsos pedio y tibial posterior son palpables.

Pregunta 1

A pesar de tener pulsos distales presentes, la sospecha de síndrome compartimental agudo es altísima. ¿Cuál es el signo clínico exploratorio más temprano, sensible y confiable para confirmar este diagnóstico en un paciente consciente?

A) Ausencia de pulso arterial

B) Dolor exacerbado al estiramiento pasivo de los músculos del compartimento afectado *

C) Parálisis motora flácida

D) Relleno capilar mayor a 5 segundos

Retroalimentación:

El dolor desproporcionado a la lesión y el dolor extremo al estiramiento pasivo de los músculos isquémicos (ej. flexión plantar pasiva de los dedos en un síndrome del compartimento anterior de la pierna) son los signos clínicos más tempranos y sensibles. La ausencia de pulsos (las "5 P": pulselessness) es un signo muy tardío y de mal pronóstico; el síndrome compartimental ocluye la microcirculación capilar y venosa mucho antes de que la presión supere a la presión arterial sistólica de los grandes vasos.

Pregunta 2

Si se decide medir las presiones intracompartimentales con un manómetro, ¿cuál es el umbral de presión diferencial (Delta P) que establece la indicación absoluta para realizar una fasciotomía quirúrgica de urgencia (liberación de los 4 compartimentos de la pierna)?

A) Presión compartimental absoluta mayor a 10 mmHg

B) Presión diferencial (Presión Diastólica menos Presión Compartimental) menor o igual a 30 mmHg *

C) Presión diferencial (Presión Sistólica menos Presión Compartimental) menor a 50 mmHg

D) Presión compartimental absoluta igual a la presión venosa central

Retroalimentación:

Actualmente, el criterio más aceptado para diagnosticar e indicar fasciotomía es el "Delta P" (ΔP). Si la diferencia entre la Presión Arterial Diastólica del paciente y la Presión Intracompartimental medida es $\leq$ 30 mmHg ($\Delta P \leq 30$), hay una isquemia tisular inminente que justifica abrir quirúrgicamente las fascias para descomprimir el tejido muscular y evitar la necrosis irremediable.

Tema: PATOLOGÍA CÁMARA POSTERIOR

Subtema: DESPRENDIMIENTO DE RETINA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 55 años, con antecedente de miopía magna (-8.0 dioptrías). Acude a urgencias oftalmológicas refiriendo que, desde hace dos días, comenzó a ver "luces relampagueantes" (fotopsias) y un aumento repentino de "moscas volantes" (miodesopsias) en su ojo derecho. El día de hoy, notó la aparición súbita de una sombra oscura ("como un telón o cortina negra") que empezó en la periferia de su campo visual inferior y está avanzando progresivamente hacia el centro, impidiéndole ver. No presenta dolor ni ojo rojo.

Pregunta 1

De acuerdo con la presentación clínica indolora y los síntomas visuales clásicos en un paciente con miopía alta, ¿cuál es el tipo de desprendimiento de retina más probable en este caso?

A) Desprendimiento de retina traccional

B) Desprendimiento de retina exudativo (seroso)

C) Desprendimiento de retina regmatógeno *

D) Desprendimiento por retinosquisis

Retroalimentación:

El desprendimiento de retina regmatógeno (del griego rhegma, rotura) es el más frecuente. Ocurre cuando un desgarro o agujero en la retina permite que el líquido del humor vítreo pase al espacio subretiniano, separando la retina neurosensorial del epitelio pigmentario subyacente. Sus pródromos clásicos son las fotopsias y miodesopsias agudas (por la tracción y rotura), seguidos de la pérdida campimétrica en "cortina". Es altamente prevalente en pacientes con miopía magna debido al adelgazamiento periférico de su retina. El tipo traccional es clásico de la retinopatía diabética proliferativa.

Tema: PATOLOGÍA BILIAR

Subtema: CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Femenina de 72 años de edad, originaria de un poblado rural, con historia de dolor crónico en hipocondrio derecho tolerado por años sin buscar atención médica. Acude a urgencias por presentar en el último mes pérdida de peso no intencionada de 8 kg, ictericia progresiva, prurito y dolor constante en el cuadrante superior derecho que ya no cede con analgésicos comunes. A la exploración física, destaca tinte ictérico en piel y escleras. A la palpación abdominal, se percibe una masa dura, fija y mal definida en el lecho vesicular, así como hepatomegalia leve.

Pregunta 1

De acuerdo con la epidemiología de esta neoplasia (que es el cáncer del tracto biliar más frecuente), ¿cuál es el factor de riesgo más fuertemente asociado y prevalente para el desarrollo del cáncer de vesícula biliar, presente en más del 80% de los pacientes diagnosticados?

A) Infección crónica por el virus de la hepatitis C

B) Consumo de alcohol crónico

C) Colelitiasis crónica (especialmente con litos mayores a 3 cm) *

D) Pólipos vesiculares de colesterol menores a 5 mm

Retroalimentación:

La presencia de cálculos biliares de larga evolución (colelitiasis crónica) es el factor de riesgo más importante para el cáncer de vesícula biliar. La irritación mecánica y la inflamación crónica continua que provocan los litos (especialmente los grandes, >3 cm) inducen displasia de la mucosa que eventualmente progresa a un carcinoma. La "vesícula en porcelana" (calcificación de la pared) es otro factor de muy alto riesgo que también es consecuencia de la inflamación crónica litiásica.

Pregunta 2

Si se realiza una biopsia de la lesión o tras la resección quirúrgica, ¿cuál es la estirpe histológica más frecuente de esta neoplasia maligna?

A) Carcinoma de células escamosas

B) Adenocarcinoma *

C) Tumor neuroendocrino

D) Linfoma MALT

Retroalimentación:

Aproximadamente el 85-90% de los cánceres de la vesícula biliar son adenocarcinomas, originados en el epitelio glandular de la mucosa biliar. Suelen ser muy agresivos y, debido a su presentación clínica tardía (cuando ya hay invasión hepática o ictericia por obstrucción de la vía biliar principal), tienen un pronóstico muy sombrío.

Tema: PATOLOGÍA ESOFÁGICA

Subtema: ACALASIA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 42 años acude a consulta externa de gastroenterología refiriendo dificultad progresiva para la deglución (disfagia) de 2 años de evolución. Menciona de manera característica que la disfagia se presenta tanto con alimentos sólidos como con líquidos desde el inicio del cuadro. Además, refiere episodios frecuentes de regurgitación de alimentos no digeridos (sin sabor ácido), especialmente por las noches al acostarse, lo que le ha provocado tos nocturna. Ha perdido 6 kg de peso en el último año.

Pregunta 1

Se le solicita un esofagograma con trago de bario como abordaje inicial. ¿Cuál es la imagen radiológica clásica y sugerente de esta patología motora que se espera encontrar en el estudio?

A) Esófago en "sacacorchos"

B) Dilatación esofágica con terminación afilada en "pico de pájaro" o "cola de ratón" *

C) Defecto de llenado irregular tipo "corazón de manzana"

D) Herniación de la cámara gástrica por encima del diafragma

Retroalimentación:

La imagen en "pico de pájaro" o "cola de ratón" en la unión esofagogástrica es el hallazgo radiológico clásico de la acalasia. Se produce por la dilatación masiva del

cuerpo esofágico (que pierde su peristalsis) y el estrechamiento distal liso y simétrico causado por la falta de relajación del esfínter esofágico inferior (EEI) al paso del contraste.

Pregunta 2

Aunque el esofagograma y la endoscopia (para descartar pseudoacalasia por cáncer) son obligatorios, ¿cuál es el estudio considerado el estándar de oro para confirmar definitivamente el diagnóstico de acalasia?

A) Manometría esofágica de alta resolución *

B) pH-metría de 24 horas

C) Tomografía computarizada de tórax

D) Gammagrafía de vaciamiento esofágico

Retroalimentación:

La manometría esofágica es el estándar de oro. Para diagnosticar acalasia clásica, la manometría debe demostrar dos alteraciones fundamentales: 1) Aperistalsis (ausencia de contracciones peristálticas normales en el cuerpo esofágico) y 2) Relajación incompleta o ausente del Esfínter Esofágico Inferior (EEI) en respuesta a la deglución.

Pregunta 3

Considerando que el paciente es joven y es un buen candidato quirúrgico, ¿cuál es el tratamiento definitivo de elección que ofrece los mejores resultados a largo plazo según la GPC?

A) Inyección endoscópica de toxina botulínica en el EEI

B) Esofagectomía total

C) Miotomía laparoscópica de Heller complementada con una funduplicatura parcial (tipo Dor o Toupet) *

D) Dilatación neumática con balón como terapia única de por vida

Retroalimentación:

La miotomía de Heller por vía laparoscópica (sección quirúrgica de las fibras musculares del EEI) es el tratamiento de elección para pacientes jóvenes con bajo riesgo quirúrgico, ya que proporciona un alivio duradero de la disfagia. Siempre debe

acompañarse de un procedimiento antirreflujo parcial (funduplicatura de Dor o Toupet) para evitar el reflujo gastroesofágico severo secundario a la destrucción del esfínter.

Tema: UROLOGÍA P1

Subtema: HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 68 años acude a su unidad de medicina familiar quejándose de síntomas del tracto urinario inferior (LUTS) de varios años de evolución. Refiere que el chorro de su orina es débil e intermitente, tiene que hacer esfuerzo (pujo) para iniciar la micción, siente que no vacía por completo la vejiga y se levanta hasta 4 veces por la noche a orinar (nicturia). Su puntaje en la escala IPSS es de 18 (síntomas moderados a severos). A la exploración, el tacto rectal revela una próstata aumentada de tamaño (grado III), de consistencia ahulada, lisa, simétrica y sin nódulos palpables. Su Antígeno Prostático Específico (APE) es de 2.5 ng/mL.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, para el manejo farmacológico inicial de este paciente con una próstata visiblemente aumentada de tamaño y síntomas molestos, se decide iniciar una terapia combinada. ¿Cuál es la familia de fármacos que actúa reduciendo el tamaño y volumen de la glándula prostática a mediano plazo y previene la progresión de la enfermedad (retención aguda de orina)?

A) Alfabloqueadores (ej. Tamsulosina)

B) Inhibidores de la 5-alfa reductasa (ej. Finasterida o Dutasterida) *

C) Antimuscarínicos (ej. Oxibutinina)

D) Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (ej. Tadalafilo)

Retroalimentación:

Los inhibidores de la 5-alfa reductasa (Finasterida/Dutasterida) bloquean la conversión de testosterona a dihidrotestosterona (DHT), el andrógeno responsable del crecimiento prostático. Tardan meses en hacer efecto, pero son los únicos que

reducen el tamaño de la próstata (hasta en un 20-30%) y modifican la historia natural de la enfermedad. Los alfabloqueadores (Tamsulosina) relajan el músculo liso para un alivio sintomático rápido (días), pero no encogen la glándula. La terapia combinada es la elección en próstatas grandes (>30-40 cc).

Tema: CIRUGÍA ONCOLOGÍA

Subtema: CÁNCER DE MAMA

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 55 años de edad, nulípara, con menopausia a los 53 años. Acude a consulta porque hace dos semanas, al bañarse, notó una "bolita" en su seno derecho. A la exploración física, las mamas son asimétricas. En el cuadrante superoexterno de la mama derecha se palpa un nódulo de 3 cm, de consistencia pétrea, bordes irregulares, fijo a planos profundos y completamente indoloro. A la inspección, se observa retracción de la piel suprayacente y un área con aspecto de "piel de naranja". Se palpan adenopatías axilares ipsilaterales duras y no dolorosas.

Pregunta 1

Por la edad de la paciente (>40 años) y los hallazgos clínicos altamente sospechosos de malignidad, ¿cuál es el estudio de imagen inicial de elección según la Norma Oficial Mexicana y la GPC para evaluar esta masa y la mama contralateral?

A) Ultrasonido mamario bilateral

B) Resonancia Magnética de mamas

C) Mastografía (Mamografía) bilateral diagnóstica *

D) Tomografía por Emisión de Positrones (PET-CT)

Retroalimentación:

La mastografía bilateral (idealmente con proyecciones adicionales o tomosíntesis si es diagnóstica) es el estudio de imagen de elección inicial (Gold Standard) para toda mujer sintomática o con hallazgos a la exploración mayor de 40 años. El ultrasonido es el estudio complementario para caracterizar nódulos sólidos vs. quísticos, y es el estudio inicial solo en mujeres menores de 35-40 años por la densidad del tejido mamario.

Pregunta 2

Se realiza una biopsia con aguja de corte (trucut) guiada por ultrasonido. ¿Cuál es el subtipo histológico más frecuente del cáncer de mama, responsable de aproximadamente el 80% de los casos invasivos?

A) Carcinoma lobulillar invasivo

B) Carcinoma ductal infiltrante (invasivo) no especificado *

C) Enfermedad de Paget del pezón

D) Carcinoma inflamatorio

Retroalimentación:

El carcinoma ductal infiltrante (ahora llamado carcinoma invasivo de tipo no especial - NST) es, por mucho, la estirpe histológica más común de cáncer de mama. El carcinoma lobulillar invasivo es el segundo en frecuencia (10-15%) y se caracteriza por ser frecuentemente bilateral y multicéntrico.

Tema: TRAUMA GENERALIDADES Y COMPLICACIONES

Subtema: PROFILAXIS ANTITETÁNICA

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 35 años, trabajador agrícola, acude al servicio de urgencias rurales tras haber pisado accidentalmente un clavo oxidado y sucio con tierra y heces de animales mientras limpiaba un establo. La herida punzante en la planta del pie derecho tiene 3 cm de profundidad. Al interrogar sobre sus antecedentes de vacunación, el paciente refiere no haber recibido ninguna vacuna desde la infancia ("esquema de vacunación desconocido"). La herida se lava exhaustivamente en urgencias y se retira el tejido necrótico.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC y los lineamientos de inmunización, ante una herida considerada "sucia o propensa a tétanos" en un paciente con esquema de

vacunación desconocido o incompleto (< 3 dosis), ¿cuál es la profilaxis antitetánica indicada?

A) Aplicación exclusiva de la vacuna (Toxoide tetánico - Td)

B) Aplicación exclusiva de Inmunoglobulina Antitetánica Humana (IgT)

C) Aplicación simultánea de la vacuna (Toxoide tetánico - Td) y la Inmunoglobulina Antitetánica Humana (IgT) en sitios anatómicos diferentes *

D) Ninguna, solo manejo con antibióticos y lavado

Retroalimentación:

En un paciente con esquema de vacunación contra el tétanos desconocido o menor a 3 dosis, la conducta depende del tipo de herida. Si la herida es limpia y menor, solo se aplica la vacuna (Toxoide/Td). Pero si la herida es sucia, punzante, contaminada con tierra/heces o tiene tejido desvitalizado (como en este caso, una herida de altísimo riesgo tetanógeno), se debe realizar profilaxis pasivo-activa simultánea: administrar la vacuna (Td) para iniciar la memoria inmunológica y la Inmunoglobulina Antitetánica (IgT) para neutralizar de inmediato cualquier toxina circulante.

Tema: PATOLOGÍA DIVERTICULAR

Subtema: DIVERTICULITIS

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 62 años, con obesidad grado I y dieta baja en fibra, acude a urgencias por presentar dolor abdominal continuo de 3 días de evolución, localizado primariamente en la fosa ilíaca izquierda, acompañado de fiebre de 38.5°C, náuseas, vómito en una ocasión y alteraciones en el hábito intestinal (estreñimiento). A la exploración física, el paciente luce agudamente enfermo, taquicárdico (110 lpm). El abdomen es doloroso a la palpación profunda en el cuadrante inferior izquierdo, con resistencia muscular y signo de rebote (Blumberg) francamente positivo en esa área. Sus laboratorios reportan leucocitosis de 16,000/mm^3 con desviación a la izquierda.

Pregunta 1

Ante la alta sospecha de una diverticulitis aguda complicada, ¿cuál es el estudio de imagen de elección (estándar de oro) que debe solicitarse para confirmar el diagnóstico, clasificar la severidad y planear el tratamiento?

A) Colonoscopia de urgencia

B) Radiografía simple de abdomen en bipedestación

C) Tomografía computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste *

D) Ultrasonido abdominal

Retroalimentación:

La TAC abdominal y pélvica contrastada es el estudio de elección para la diverticulitis aguda. Permite confirmar el diagnóstico, evaluar la extensión de la inflamación pericólica y detectar complicaciones (abscesos, perforación libre, fístulas), estadificando la enfermedad según la clasificación de Hinchey. La colonoscopia está absolutamente contraindicada en el cuadro agudo por el altísimo riesgo de perforar el colon inflamado.

Pregunta 2

La TAC revela engrosamiento de la pared del colon sigmoides, inflamación de la grasa pericólica y la presencia de un absceso pélvico (distante al sitio de la inflamación primaria) de 6 centímetros de diámetro. No hay evidencia de gas libre ni peritonitis generalizada. De acuerdo con la clasificación tomográfica de Hinchey, ¿en qué estadio se encuentra este paciente?

A) Hinchey I

B) Hinchey II *

C) Hinchey III

D) Hinchey IV

Retroalimentación:

La clasificación de Hinchey modificada evalúa los hallazgos tomográficos y quirúrgicos: Hinchey I (absceso pericólico localizado o flemón); Hinchey II (absceso pélvico, intrabdominal distante o retroperitoneal); Hinchey III (peritonitis purulenta generalizada); Hinchey IV (peritonitis fecaloidea). La presencia de un absceso pélvico distante de 6 cm corresponde a un estadio II.

Pregunta 3

Con base en la GPC para el manejo de la diverticulitis Hinchey II con un absceso mayor a 4-5 cm, ¿cuál es el manejo terapéutico inicial de elección para evitar una cirugía de urgencia con estoma?

A) Antibioticoterapia intravenosa exclusiva y observación

B) Drenaje percutáneo guiado por imagen (TAC o USG) más antibióticos IV *

C) Resección de sigmoides con anastomosis primaria inmediata

D) Procedimiento de Hartmann de urgencia

Retroalimentación:

Para los abscesos mayores a 4-5 cm (frecuentes en Hinchey II y algunos Hinchey Ib), el tratamiento de elección es el drenaje percutáneo guiado por imagen apoyado por antibióticos intravenosos. Esto permite controlar el foco séptico de manera mínimamente invasiva, "enfriando" el cuadro para poder realizar una resección electiva con anastomosis primaria semanas después, evitando así una colostomía de urgencia.

Tema: INTRODUCCIÓN OFTALMOLOGÍA

Subtema: GLAUCOMA

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 65 años, hipermétrope. Es llevada a urgencias oftalmológicas por inicio súbito (hace 2 horas) de dolor ocular derecho insoportable, hemicraneal, acompañado de náuseas intensas y vómito. Refiere que su visión se tornó muy borrosa y ve "halos de colores" alrededor de las luces. A la exploración, el ojo derecho presenta inyección ciliar severa (ojo rojo). La pupila está en midriasis media y fija (arreactiva a la luz). La córnea se observa opaca, deslustrada (edema corneal). A la palpación bidigital, el globo ocular derecho se siente extremadamente duro, "como una canica de vidrio".

Pregunta 1

Por la presentación aguda, dolorosa y los hallazgos en la exploración física, ¿cuál es el diagnóstico clínico de emergencia?

A) Uveítis anterior aguda

B) Glaucoma primario de ángulo abierto

C) Glaucoma agudo de ángulo cerrado *

D) Endoftalmitis endógena

Retroalimentación:

El glaucoma agudo de ángulo cerrado es una emergencia oftalmológica caracterizada por el bloqueo súbito del drenaje del humor acuoso, elevando la presión intraocular a niveles muy altos (a menudo >50 mmHg). Esto causa dolor extremo, náuseas, edema corneal (visión borrosa y halos), pupila en midriasis media fija (por isquemia del esfínter del iris) y un ojo duro a la palpación. El glaucoma de ángulo abierto, por el contrario, es crónico, indoloro y asintomático hasta etapas finales.

Pregunta 2

Tras el manejo médico agudo inicial (manitol IV, acetazolamida oral, pilocarpina y betabloqueadores tópicos) para romper el bloqueo y disminuir la presión intraocular, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico definitivo de elección para prevenir recurrencias en este ojo y como profilaxis en el ojo contralateral?

A) Trabeculectomía quirúrgica

B) Iridotomía periférica con láser Nd:YAG *

C) Colocación de válvula de Ahmed

D) Enucleación del globo ocular

Retroalimentación:

Una vez controlada la crisis hipertensiva aguda, el tratamiento definitivo y preventivo (incluso para el ojo sano, por predisposición anatómica) es la iridotomía periférica con láser. Este procedimiento crea un pequeño orificio en el iris periférico, estableciendo una vía de comunicación alternativa para que el humor acuoso pase de la cámara posterior a la anterior, puenteando el bloqueo pupilar.

Tema: UROLOGÍA P1

Subtema: TORSIÓN TESTICULAR

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 14 años es traído a urgencias durante la madrugada. Refiere inicio súbito de dolor escrotal derecho de extrema intensidad que lo despertó del sueño, irradiado a la región inguinal y abdominal baja, acompañado de náuseas. No hay antecedentes de trauma ni síntomas urinarios. A la exploración física, el testículo derecho está aumentado de tamaño, indurado, eritematoso y se encuentra ascendido en el escroto con un eje transversal (horizontalizado). El reflejo cremastérico derecho está ausente. Al elevar manualmente el testículo derecho, el dolor del paciente no disminuye, e incluso parece empeorar (Signo de Prehn negativo).

Pregunta 1

Dado el cuadro clínico agudo en un adolescente y los hallazgos exploratorios patognomónicos, ¿cuál es el diagnóstico de presunción que constituye una verdadera urgencia urológica?

A) Epididimitis aguda

B) Torsión testicular *

C) Orquitis viral (parotiditis)

D) Hernia inguinal encarcelada

Retroalimentación:

La torsión testicular clásica ocurre en adolescentes. Se presenta con dolor escrotal súbito e intenso, frecuentemente durante el sueño. Los signos clínicos cardinales son: testículo ascendido y horizontalizado (deformidad en badajo de campana), pérdida del reflejo cremastérico ipsilateral y un signo de Prehn negativo (la elevación del testículo no alivia el dolor, a diferencia de la epididimitis donde sí suele aliviarlo [Prehn positivo]).

Pregunta 2

Ante la altísima sospecha clínica de esta entidad y considerando que la viabilidad del testículo disminuye drásticamente después de las primeras 6 horas, ¿cuál es la conducta médica inicial más apropiada si el ultrasonido Doppler no está disponible inmediatamente en los próximos 20 minutos?

A) Administrar antibióticos intravenosos empíricos y analgésicos

B) Diferir el manejo hasta conseguir el ultrasonido Doppler institucional

C) Exploración quirúrgica de urgencia inmediata para destorsión y orquidopexia bilateral *

D) Intentar reducción manual exclusiva en urgencias y dar de alta

Retroalimentación:

El "tiempo es testículo". La torsión testicular es una urgencia quirúrgica absoluta. Si el cuadro clínico es clásico, no se debe retrasar la cirugía esperando un ultrasonido Doppler. La conducta correcta es la exploración escrotal quirúrgica urgente para destorcer el cordón espermático, evaluar la viabilidad y realizar orquidopexia (fijación) bilateral (ya que el defecto anatómico suele ser bilateral).

Tema: TRAUMA GENERALIDADES Y COMPLICACIONES

Subtema: ATB EN TRAUMA Y PROFILAXIS QX

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 45 años, programada para una colecistectomía laparoscópica electiva por colelitiasis sintomática (cólicos biliares de repetición), sin datos actuales de colecistitis aguda o infección de vías biliares. El procedimiento se considera una cirugía limpia-contaminada, por lo que se decide indicar profilaxis antibiótica perioperatoria con Cefazolina intravenosa.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC y los estándares de seguridad quirúrgica para la prevención de infecciones del sitio quirúrgico, ¿cuál es el momento ideal y exacto en el que debe administrarse la dosis de este antibiótico profiláctico?

A) Tres días antes de la intervención quirúrgica

B) En los primeros 60 minutos previos a la incisión quirúrgica (idealmente durante la inducción anestésica) *

C) Exclusivamente al finalizar el cierre de la piel en quirófano

D) 24 horas después de la cirugía en piso de hospitalización

Retroalimentación:

El objetivo de la profilaxis antibiótica es lograr concentraciones bactericidas tisulares y séricas adecuadas al momento en que se abre la piel. Para lograr esto con la mayoría de los antibióticos (como las cefalosporinas), la dosis debe administrarse de manera intravenosa dentro de los 60 minutos previos a la incisión cutánea. Darlo mucho antes o después de iniciada la cirugía pierde su eficacia profiláctica.

Tema: PATOLOGÍA DE EXTREMIDAD SUPERIOR

Subtema: Fx de clavicula

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 20 años sufre una caída lateral sobre el hombro derecho mientras andaba en bicicleta. Acude a urgencias sosteniendo su brazo derecho pegado al cuerpo con su mano izquierda. Refiere dolor intenso y limitación funcional de la extremidad superior derecha. A la exploración física, se observa una evidente deformidad, aumento de volumen, equimosis y crepitación ósea a la palpación en la región clavicular derecha.

Pregunta 1

Teniendo en cuenta la anatomía biomecánica de este hueso y la epidemiología traumatológica, ¿en qué porción anatómica de la clavícula se localiza la gran mayoría (aproximadamente 80%) de estas fracturas?

A) Tercio distal (lateral)

B) Tercio proximal (medial)

C) Tercio medio (diáfisis) *

D) Articulación esternoclavicular

Retroalimentación:

Aproximadamente el 80% de todas las fracturas de clavícula ocurren en el tercio medio (diafisiarias). Esta región es la más vulnerable debido a que es la zona de transición anatómica donde la clavícula cambia su curvatura, carece de protección muscular y ligamentaria fuerte, y es el punto donde se concentran las fuerzas de

compresión axial transmitidas desde el hombro durante las caídas. El tratamiento suele ser conservador (cabestrillo o vendaje en 8) si no hay gran desplazamiento.

Tema: CIRUGÍA ONCOLOGÍA

Subtema: CÁNCER DE TIROIDES

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 35 años, sin antecedentes familiares de importancia ni exposición a radiación, acude a consulta por notar un aumento de volumen en la región anterior del cuello de crecimiento lento durante los últimos 6 meses. Se encuentra asintomática, negando disfagia, disfonía o síntomas de hipertiroidismo. A la exploración física, se palpa un nódulo tiroideo en el lóbulo derecho, de aproximadamente 3 cm, de consistencia firme, no doloroso y móvil a la deglución. Las pruebas de función tiroidea (TSH y T4 libre) se reportan dentro de rangos normales. Se solicita un ultrasonido de cuello que reporta un nódulo sólido, hipoecoico, de márgenes irregulares y con presencia de microcalcificaciones.

Pregunta 1

Por las características ecográficas de alta sospecha, se realiza una Biopsia por Aspiración con Aguja Fina (BAAF). El reporte citológico describe la presencia de células con núcleos ópticamente claros, vacíos, con inclusiones citoplasmáticas intranucleares e hendiduras longitudinales. ¿Qué nombre clásico reciben estos hallazgos nucleares patognomónicos?

A) Células de Hürthle

B) Cuerpos de psamoma

C) Núcleos en "ojo de la huerfanita Annie" *

D) Células en "anillo de sello"

Retroalimentación:

Los núcleos ópticamente claros o vacíos, conocidos clásicamente como núcleos en "ojo de la huerfanita Annie" (Orphan Annie eyes), junto con los cuerpos de psamoma, son los hallazgos citológicos y patológicos patognomónicos del carcinoma papilar de tiroides, que es la neoplasia maligna más frecuente del sistema endocrino.

Pregunta 2

Confirmado el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides, ¿cuál es la vía de diseminación metastásica primaria y más frecuente de esta estirpe histológica en particular, que justifica la evaluación intraoperatoria de los compartimentos del cuello?

A) Diseminación hematógena hacia pulmón y hueso

B) Diseminación linfática hacia los ganglios cervicales *

C) Extensión local hacia la tráquea exclusivamente

D) Siembra peritoneal

Retroalimentación:

El carcinoma papilar de tiroides (el más frecuente y de mejor pronóstico) tiene una fuerte predilección por la diseminación por vía linfática hacia los ganglios linfáticos regionales del cuello (compartimento central y laterocervical), presentándose con metástasis ganglionares hasta en un 30-40% de los casos al diagnóstico. En contraste, el carcinoma folicular se disemina primariamente por vía hematógena (hueso, pulmón).

Tema: HERNIAS / ESPLENECTOMÍA

Subtema: HERNIA INGUINAL

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 45 años, de ocupación cargador en la central de abastos. Acude a la consulta externa quejándose de la aparición de un "bulto" en la región inguinal derecha que aumenta de tamaño al final del día laboral o al cargar objetos pesados, y que desaparece al acostarse. A la exploración física en bipedestación, se le pide al paciente que realice la maniobra de Valsalva, observándose la protrusión de una masa en la región inguinocrural derecha. Al realizar la exploración digital del conducto inguinal, el médico percibe que la hernia protruye rozando la punta de su dedo (bajando por el canal) y, ecográficamente, se confirma que el defecto tiene su origen lateral a los vasos epigástricos inferiores.

Pregunta 1

De acuerdo con los límites anatómicos (Triángulo de Hesselbach) y el origen lateral respecto a los vasos epigástricos inferiores, ¿cuál es el diagnóstico anatómico correcto de esta hernia?

A) Hernia inguinal directa

B) Hernia femoral

C) Hernia inguinal indirecta *

D) Hernia obturatriz

Retroalimentación:

La relación anatómica clave para clasificar las hernias inguinales es su posición respecto a los vasos epigástricos inferiores. Las hernias que protruyen por fuera (lateral) de los vasos epigástricos a través del anillo inguinal profundo y descienden por el conducto inguinal son hernias indirectas (las más frecuentes en todas las edades). Las que protruyen por dentro (medial) de los vasos, directamente a través de un defecto en la fascia transversal (Triángulo de Hesselbach), son hernias directas.

Shutterstock

Explorar

Tema: UROLOGÍA P2

Subtema: CÁNCER UROTELIAL Y TESTICULAR

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 65 años, trabajador jubilado de una fábrica de pinturas y fumador crónico (índice tabáquico de 40 paquetes/año). Acude a consulta urológica refiriendo que, en las últimas tres semanas, ha notado que su orina es de color rojo franco y en ocasiones presenta coágulos. Menciona que este sangrado es completamente indoloro y no se acompaña de ardor, fiebre, ni molestias para orinar (disuria). Su tacto rectal reporta una próstata grado I, lisa y sin nódulos. Un examen general de orina

confirma la presencia de hematuria macroscópica masiva sin datos de infección (nitritos y leucocitosis negativos).

Pregunta 1

De acuerdo con la epidemiología urológica, ¿cuál es el diagnóstico más importante que se debe sospechar y descartar de manera urgente ante el cuadro de hematuria macroscópica indolora en un paciente mayor y fumador?

A) Hiperplasia prostática benigna

B) Litiasis coraliforme

C) Cáncer urotelial de vejiga *

D) Prostatitis crónica

Retroalimentación:

Toda hematuria macroscópica indolora en pacientes mayores de 50 años (especialmente si son fumadores o están expuestos a aminas aromáticas/tintes) debe considerarse como un cáncer de vejiga (carcinoma urotelial o de células transicionales) hasta demostrar lo contrario. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante (responsable del 50% de los casos).

Pregunta 2

Para confirmar el diagnóstico, evaluar la anatomía de las vías urinarias bajas y, si es posible, tomar una biopsia o realizar la resección de la lesión, ¿cuál es el estudio endoscópico de primera elección y estándar de oro a solicitar?

A) Ultrasonido pélvico suprapúbico

B) Tomografía computarizada simple de abdomen

C) Cistoscopia (Uretrocistoscopia) *

D) Resonancia magnética multiparamétrica de pelvis

Retroalimentación:

La cistoscopia flexible o rígida es el estándar de oro para el diagnóstico del cáncer de vejiga. Permite la visualización directa de la mucosa vesical, la identificación del tumor (usualmente de aspecto papilar o "en coliflor") y la toma de biopsias o la resección transuretral del tumor de vejiga (RTUV) para el diagnóstico histopatológico definitivo.

Pregunta 3

La cistoscopia revela un tumor papilar friable de 3 cm en la pared lateral izquierda. Se realiza una Resección Transuretral de Vejiga (RTUV) completa. El reporte de patología indica un "Carcinoma Urotelial Papilar de Alto Grado, no músculo-invasivo (T1)". Según las guías internacionales, ¿cuál es el tratamiento adyuvante intravesical de elección para disminuir el altísimo riesgo de recurrencia y progresión en tumores de alto grado no invasivos?

A) Radioterapia externa a dosis totales

B) Cistectomía radical inmediata

C) Instilación intravesical del bacilo de Calmette-Guérin (BCG) *

D) Quimioterapia sistémica con Cisplatino

Retroalimentación:

Para el cáncer de vejiga no músculo-invasivo (estadios Ta, T1, o CIS) de alto riesgo, el tratamiento estándar post-RTUV es la inmunoterapia intravesical con la vacuna BCG (Bacilo de Calmette-Guérin). Esta terapia estimula una reacción inmunitaria e inflamatoria masiva localizada en la mucosa vesical que destruye las células cancerosas residuales, reduciendo significativamente la tasa de recurrencia y la progresión hacia un cáncer músculo-invasivo.

Tema: PATOLOGÍA DE EXTREMIDAD INFERIOR

Subtema: Fx de cadera

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 82 años, con diagnóstico de osteoporosis severa. Sufre una caída desde su propia altura al resbalar en el baño, golpeándose directamente sobre el trocánter mayor derecho. Es traída a urgencias quejándose de dolor intenso en la ingle derecha e incapacidad absoluta para deambular o mover la extremidad. A la inspección en la camilla, se observa la extremidad inferior derecha francamente acortada y en rotación externa evidente (el borde externo del pie toca la camilla). No hay exposición ósea ni heridas.

Pregunta 1

El cuadro clínico de acortamiento y rotación externa marcada tras una caída en una paciente anciana es patognomónico de una entidad traumatológica. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Luxación posterior de cadera

B) Fractura diafisiaria de fémur

C) Fractura del extremo proximal del fémur (Fractura de cadera) *

D) Fractura de la rama isquiopúbica

Retroalimentación:

La fractura de cadera (ya sea intracapsular como la de cuello femoral, o extracapsular como la intertrocantérica) presenta el cuadro clínico clásico de acortamiento y rotación externa de la extremidad. Esto se debe a la tracción sin oposición de los músculos rotadores externos cortos y los músculos glúteos/psoas ilíaco que tiran del fragmento distal hacia arriba. Por el contrario, la luxación posterior de cadera se presenta clásicamente con la extremidad acortada pero en rotación interna (posición del bañista sorprendido).

Pregunta 2

Se toma una radiografía de pelvis que confirma una fractura desplazada del cuello femoral derecho (fractura intracapsular transcervical). Debido a la precaria irrigación anatómica de esta zona en particular, ¿cuál es la complicación local tardía más temida y frecuente que dicta que en pacientes ancianos se prefiera colocar una prótesis en lugar de osteosíntesis (tornillos)?

A) Síndrome compartimental del muslo

B) Necrosis avascular (osteonecrosis) de la cabeza femoral *

C) Pseudoartrosis hipertrófica

D) Tromboembolia pulmonar

Retroalimentación:

Las fracturas del cuello femoral (intracapsulares) interrumpen el flujo sanguíneo retrógrado que aportan las arterias circunflejas femorales medial y lateral a la cabeza

del fémur. Por ello, tienen un altísimo riesgo de desarrollar necrosis avascular y no unión (pseudoartrosis). Esta es la razón principal por la que en pacientes ancianos se prefiere retirar la cabeza isquémica y realizar una artroplastia (prótesis parcial o total de cadera) desde el inicio, permitiendo un apoyo y movilización inmediatos.

Tema: PATOLOGÍA INTESTINAL QX

Subtema: OCLUSION INTESTINAL

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 50 años, con antecedente de una apendicectomía abierta complicada por peritonitis hace 10 años. Acude a urgencias refiriendo dolor abdominal difuso de tipo cólico (intermitente) intenso, de 24 horas de evolución, acompañado de náuseas y vómitos de contenido fecaloide en repetidas ocasiones. Refiere imposibilidad para evacuar o canalizar gases desde que inició el dolor. A la exploración física, presenta abdomen distendido, timpánico a la percusión, con peristalsis aumentada ("ruidos de lucha") pero sin datos francos de irritación peritoneal (rebote negativo).

Pregunta 1

Se solicita una radiografía de abdomen en bipedestación que muestra múltiples niveles hidroaéreos en escalera y asas de intestino delgado dilatadas centralmente, con ausencia de gas en el colon y ámpula rectal. Dado este hallazgo y sus antecedentes quirúrgicos, ¿cuál es la causa más frecuente de este cuadro obstructivo a nivel mundial?

A) Hernia inguinal encarcelada

B) Vólvulo de sigmoides

C) Adherencias postoperatorias (bridas) *

D) Cáncer colorrectal estenosante

Retroalimentación:

La clínica (dolor cólico, vómito fecaloide, ausencia de gases) y la radiografía (dilatación de asas de intestino delgado con niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal) son clásicas de una oclusión intestinal mecánica de intestino delgado. En

pacientes con antecedente de cirugías abdominales previas (laparotomías), las adherencias o bridas peritoneales son, por mucho, la causa número uno de obstrucción del intestino delgado. En pacientes sin cirugías previas, las hernias encarceladas ocupan el primer lugar.

Tema: PATOLOGÍA PERIANAL

Subtema: FISURA ANAL

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 30 años, con antecedente de estreñimiento crónico, acude a consulta quejándose de dolor anal extremo, lacerante y transfixiante que se presenta durante y minutos después de la defecación. La paciente refiere tener "miedo a ir al baño" por el intenso dolor, y menciona haber notado estrías de sangre roja brillante en el papel higiénico. A la exploración física cuidadosa (separando los glúteos), se observa un desgarro longitudinal en el epitelio escamoso del canal anal, localizado exactamente en la línea media posterior.

Pregunta 1

Debido a que la paciente refiere tener estos síntomas desde hace más de 8 semanas, se considera una fisura anal crónica. Además de la úlcera o desgarro en sí, ¿cuáles son los otros dos componentes anatómicos que conforman la clásica Tríada de Brodie?

A) Hemorroide interna prolapsada y absceso interesfintérico

B) Fístula perianal subcutánea y criptitis

C) Pólipo centinela (en el margen distal) y papila anal hipertrófica (en el margen proximal) *

D) Colgajo cutáneo redundante y prolapso mucoso circunferencial

Retroalimentación:

La fisura anal crónica (de más de 6-8 semanas de evolución) se acompaña típicamente de la Tríada de Brodie: 1) La fisura anal (úlcera con fibras del esfínter interno expuestas), 2) Una papila anal hipertrófica en el extremo proximal (hacia la línea dentada) y 3) Un colgajo cutáneo o "pólipo centinela" en el extremo distal (borde

anal). La gran mayoría de las fisuras (90%) ocurren en la línea media posterior debido a la menor perfusión sanguínea en esta zona.

Tema: CIRUGÍA ONCOLOGÍA

Subtema: CÁNCER GÁSTRICO

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 65 años, originario de una comunidad con alta ingesta de alimentos ahumados y salados, con tabaquismo crónico positivo. Acude a consulta por pérdida de peso no intencionada de 10 kg en 4 meses, saciedad temprana, astenia, adinamia y molestia sorda en el epigastrio. A la exploración física, el paciente presenta palidez de tegumentos. A la palpación de las cadenas ganglionares, destaca un nódulo indurado, fijo e indoloro en la fosa supraclavicular izquierda. Sus laboratorios de rutina muestran anemia microcítica hipocrómica (Hb 9.0 g/dL, VCM 72 fL).

Pregunta 1

El hallazgo exploratorio del ganglio palpable en la fosa supraclavicular izquierda es un signo clásico de diseminación metastásica linfática de neoplasias intraabdominales (especialmente cáncer gástrico). ¿Qué epónimo recibe este signo clínico?

A) Ganglio de la hermana María José

B) Escudo de Blumer

C) Ganglio de Irish

D) Ganglio de Virchow *

Retroalimentación:

El Ganglio de Virchow es la adenopatía supraclavicular izquierda metastásica (ya que en ese lado desemboca el conducto torácico que recoge la linfa del abdomen). Otros signos de metástasis a distancia en cáncer gástrico incluyen: Ganglio de la hermana María José (nódulo periumbilical), Escudo de Blumer (masa palpable en el fondo de saco de Douglas al tacto rectal), Tumor de Krukenberg (metástasis a ovarios) y Ganglio de Irish (ganglio axilar anterior izquierdo).

Pregunta 2

Se realiza una endoscopia superior que revela una gran lesión ulcerada con bordes irregulares y elevados en el cuerpo gástrico. Las biopsias confirman un adenocarcinoma. Según la clasificación histopatológica de Lauren, ¿cuál es el subtipo de adenocarcinoma gástrico que se caracteriza por formar estructuras glandulares, afectar a pacientes mayores, y estar fuertemente asociado a factores ambientales (dieta, H. pylori, metaplasia intestinal)?

A) Subtipo difuso

B) Subtipo intestinal *

C) Subtipo escamoso

D) Subtipo mucinoso

Retroalimentación:

La clasificación de Lauren divide al adenocarcinoma gástrico en dos tipos principales: El tipo intestinal (forma glándulas, se asocia fuertemente a factores ambientales y cascada de Correa [gastritis crónica -> atrofia -> metaplasia intestinal -> displasia -> cáncer], mejor pronóstico, diseminación hematógena) y el tipo difuso (no forma glándulas, afecta a jóvenes, se asocia al grupo sanguíneo A y mutaciones del gen CDH1/E-cadherina, tiene células en anillo de sello, diseminación linfática y peor pronóstico).

Pregunta 3

Si durante el escrutinio se detectara un "cáncer gástrico temprano" (Early Gastric Cancer), el cual se define estrictamente como un tumor confinado a la mucosa o submucosa, sin importar el estado ganglionar. ¿Cuál sería el tratamiento curativo mínimamente invasivo de elección si el tumor cumple con los criterios para no resección quirúrgica formal (confinado a la mucosa, < 2 cm, no ulcerado, tipo intestinal)?

A) Gastrectomía total abierta con disección ganglionar D2

B) Quimioterapia neoadyuvante exclusiva

C) Resección endoscópica de la mucosa (REM) o Disección submucosa endoscópica (DSE) *

D) Derivación gastroyeyunal paliativa

Retroalimentación:

El cáncer gástrico incipiente (temprano) detectado a tiempo (limitado a la mucosa, bien diferenciado, pequeño) tiene un riesgo de metástasis ganglionar casi nulo. En estos casos muy selectos, la resección o disección endoscópica (extirpar el tumor a través de la endoscopia sin necesidad de abrir el abdomen ni quitar el estómago) es el tratamiento curativo de elección, preservando por completo la función gástrica.

Tema: PATOLOGÍA BILIAR

Subtema: QUISTES DEL COLÉDOCO

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 8 años de edad, llevada a urgencias por su madre por presentar dolor abdominal intermitente en el cuadrante superior derecho, ictericia leve recurrente y un pico febril aislado de 38°C. A la exploración física de la paciente, se palpa una masa blanda, renitente y poco dolorosa en el hipocondrio derecho. Se solicita un ultrasonido abdominal que revela una dilatación quística fusiforme localizada exclusivamente en el conducto colédoco (vía biliar extrahepática), sin dilatación ni alteraciones en la vía biliar intrahepática.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación anatómica de Todani para la dilatación quística de las vías biliares, ¿a qué tipo corresponde la dilatación fusiforme exclusiva de la vía biliar extrahepática documentada en esta paciente, siendo además la presentación más frecuente (80-90% de los casos)?

A) Tipo I *

B) Tipo II

C) Tipo III (Coledococele)

D) Tipo V (Enfermedad de Caroli)

Retroalimentación:

La clasificación de Todani estadifica los quistes biliares. El Tipo I (dilatación quística, sacular o fusiforme del colédoco/vía extrahepática) es el más común (hasta 90%). El Tipo II es un divertículo verdadero del colédoco. El Tipo III es una dilatación intraduodenal (coledococele). El Tipo IV es dilatación intra y extrahepática múltiple. El Tipo V (Enfermedad de Caroli) son múltiples dilataciones saculares exclusivamente intrahepáticas.

Pregunta 2

Debido al alto riesgo (hasta del 30%) de degeneración maligna hacia colangiocarcinoma en la edad adulta por el estancamiento biliar y la irritación crónica, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico definitivo de elección para esta paciente?

A) Esfinterotomía endoscópica de urgencia

B) Drenaje percutáneo guiado por ultrasonido

C) Derivación quistoduodenal interna dejando el quiste in situ

D) Escisión completa del quiste con reconstrucción bilioentérica (Hepaticoyeyunostomía en Y de Roux) *

Retroalimentación:

El tratamiento de elección para los quistes de colédoco Tipo I es la extirpación quirúrgica completa de la vía biliar dilatada (para eliminar de raíz el riesgo de cáncer) seguida de una reconstrucción mediante una anastomosis entre el conducto hepático común restante y una porción aislada de intestino delgado (Hepaticoyeyunostomía en Y de Roux) para restablecer el drenaje biliar de forma segura.

Tema: TRAUMA GENERALIDADES Y COMPLICACIONES

Subtema: CHOQUE HIPOVOLÉMICO HEMORRÁGICO

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 35 años sufre amputación traumática de la pierna izquierda a nivel del tercio medio de la tibia tras quedar atrapado en maquinaria agrícola. A su ingreso a la sala de choque, los paramédicos han colocado un torniquete proximal funcional. El paciente se encuentra confuso y muy ansioso. Sus signos vitales muestran: FC 135

lpm, TA 85/50 mmHg, FR 32 rpm. La diuresis medida tras la colocación de sonda Foley es de 10 ml/h (oliguria).

Pregunta 1

Basado en los parámetros clínicos descritos por el ATLS (frecuencia cardíaca >120 lpm, hipotensión franca, confusión y taquipnea severa), ¿a qué clase de choque hemorrágico corresponde el estado del paciente, el cual implica una pérdida estimada del 31-40% de su volumen sanguíneo (aproximadamente 1,500 a 2,000 ml)?

A) Choque Clase I

B) Choque Clase II

C) Choque Clase III *

D) Choque Clase IV

Retroalimentación:

El ATLS clasifica el choque hemorrágico en 4 grados. La clave clínica principal del Clase III es la aparición franca de hipotensión sistólica (la presión arterial se mantiene normal en la clase I y II por mecanismos compensatorios), taquicardia >120 lpm, confusión mental y oliguria marcada, indicando una pérdida del 31 al 40% del volumen sanguíneo total. El Clase IV es pre-morten (FC >140, letargo/coma, anuria).

Pregunta 2

Según la 10ª edición del ATLS, ¿cuál es la estrategia de reanimación hídrica inicial recomendada en este paciente para evitar la "coagulopatía dilucional" y la "tríada letal" del trauma?

A) Infusión rápida de 3 a 4 litros de solución salina al 0.9%

B) Reanimación de control de daños con inicio temprano de hemoderivados (sangre/plasma/plaquetas) y uso restrictivo de cristaloides (1 litro inicial) *

C) Infusión continua de coloides sintéticos exclusivamente

D) Administración de vasopresores (Norepinefrina) como primera línea

Retroalimentación:

El paradigma de reanimación ha cambiado. El ATLS actual desaconseja fuertemente la infusión masiva de cristaloides (>1.5L) porque diluye los factores de coagulación,

causa hipotermia y empeora el sangrado (coagulopatía dilucional). La recomendación actual es la reanimación hemostática o de "control de daños": administrar un bolo inicial pequeño (1 litro) de cristaloides calentados (Ringer Lactato) e iniciar de forma temprana y balanceada la transfusión de sangre total o hemoderivados en proporción 1:1:1 (Paquetes globulares, plasma fresco congelado y plaquetas) para un paciente en choque Clase III o IV.

Tema: INTRODUCCIÓN OFTALMOLOGÍA

Subtema: RETINOBLASTOMA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Lactante masculino de 18 meses de edad, es traído a su primera revisión oftalmológica porque sus padres notaron desde hace un mes un "brillo blanco" en la pupila del ojo derecho del bebé, el cual se hace muy evidente cuando le toman fotografías con flash (ausencia del reflejo rojo normal). A la exploración física ocular, el ojo derecho presenta estrabismo convergente (endotropia) y se confirma mediante oftalmoscopia el reflejo pupilar blanco. No hay antecedentes heredofamiliares conocidos de cáncer ocular.

Pregunta 1

El hallazgo de leucocoria (pupila blanca) en un paciente pediátrico es el signo de presentación clínica más común (60% de los casos) de esta grave neoplasia intraocular maligna primaria. Desde el punto de vista de la biología molecular, el retinoblastoma se desarrolla por la mutación e inactivación de ambos alelos del gen supresor de tumores RB1. ¿En qué cromosoma se localiza este gen específico?

A) Cromosoma 5q21

B) Cromosoma 17p

C) Cromosoma 13q14 *

D) Cromosoma 11p13

Retroalimentación:

El retinoblastoma es el tumor intraocular maligno primario más común en la infancia, presentándose clínicamente con leucocoria y estrabismo. Es el ejemplo clásico de la "teoría del doble impacto" (Two-Hit Hypothesis) de Knudson. La enfermedad se desarrolla por la inactivación o mutación de las dos copias del gen supresor de tumores RB1, el cual se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 13, banda 14 (13q14).

Tema: UROLOGÍA P2

Subtema: CÁNCER DE PENE

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 65 años, no circuncidado, con tabaquismo crónico intenso. Acude a consulta urológica por presentar una lesión ulcerada y exofítica en el glande de 4 meses de evolución, la cual es indolora, indurada, de bordes evertidos y sangra fácilmente al roce de la ropa interior. Refiere secreción purulenta y fétida por debajo del prepucio (fimosis crónica). A la exploración física, además de la lesión descrita, se palpan adenopatías inguinales bilaterales duras y fijas.

Pregunta 1

Teniendo en cuenta los factores de riesgo (falta de circuncisión, fimosis crónica, tabaquismo y posible infección por VPH), ¿cuál es el tipo histológico que representa más del 95% de las neoplasias malignas de pene?

A) Melanoma maligno

B) Adenocarcinoma

C) Carcinoma de células escamosas (epidermoide) *

D) Sarcoma de Kaposi

Retroalimentación:

El carcinoma de células escamosas (epidermoide) es responsable del 95% de los cánceres de pene. Sus principales factores de riesgo son la falta de higiene (esmegma) secundaria a fimosis por no estar circuncidado, el tabaquismo y la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH), principalmente los serotipos 16 y 18.

Tema: PATOLOGÍA INTESTINAL QX

Subtema: CÁNCER COLORRECTAL

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 72 años acude a consulta por referir pérdida de peso progresiva (8 kg en 3 meses), astenia, adinamia y cambios recientes en el hábito intestinal. El paciente menciona que sus evacuaciones se han vuelto muy delgadas ("en forma de lápiz") y ocasionalmente nota estrías de sangre roja oscura mezclada con las heces. Sus estudios de laboratorio revelan una anemia microcítica hipocrómica (Hb 10.2 g/dL).

Pregunta 1

Se solicita un colon por enema con doble contraste como parte del abordaje inicial por la falta de disponibilidad inmediata de colonoscopia. El estudio reporta una estenosis concéntrica severa y corta en el colon descendente con bordes "colgantes". ¿Qué nombre recibe este clásico signo radiológico, altamente sugestivo de un adenocarcinoma estenosante?

A) Signo del grano de café

B) Signo del pico de pájaro

C) Signo de la "manzana mordida" (o corazón de manzana) *

D) Signo del apilamiento de monedas

Retroalimentación:

El signo de la "manzana mordida" o "corazón de manzana" (apple-core lesion) en un colon por enema es la imagen clásica y patognomónica de un carcinoma colorrectal estenosante, típico del colon izquierdo (descendente y sigmoides). El tumor crece circunferencialmente estrechando la luz del colon, lo que explica la clínica de heces delgadas y la obstrucción progresiva.

Pregunta 2

Tras confirmar el diagnóstico mediante colonoscopia y biopsia, el paciente es programado para tratamiento quirúrgico oncológico (Hemicolectomía izquierda radical). ¿Cuál es el marcador tumoral sérico de elección que debe solicitarse antes

de la cirugía para establecer un valor basal y utilizarse posteriormente en el seguimiento postoperatorio para detectar recurrencias tempranas?

A) CA 19-9

B) Alfa-fetoproteína (AFP)

C) Antígeno Carcinoembrionario (ACE) *

D) CA 125

Retroalimentación:

El Antígeno Carcinoembrionario (ACE o CEA) es el marcador tumoral de elección para el cáncer colorrectal. No es útil como prueba de tamizaje diagnóstico debido a su baja sensibilidad y especificidad inicial, pero es fundamental para el seguimiento posquirúrgico, ya que su elevación progresiva tras una cirugía curativa es el primer indicador de una recurrencia local o metástasis a distancia.

Pregunta 3

En el estudio de estadificación (Tomografía toracoabdominopélvica), el médico debe buscar intencionadamente la diseminación hematógena. Debido al drenaje venoso del colon a través del sistema porta, ¿cuál es el órgano que representa el sitio más frecuente de metástasis a distancia en el cáncer colorrectal?

A) Cerebro

B) Hueso

C) Pulmón

D) Hígado *

Retroalimentación:

El hígado es el sitio más común de metástasis a distancia en el cáncer colorrectal (ocurriendo hasta en un 50% de los pacientes en algún momento de su enfermedad). Esto se debe a que el retorno venoso del colon y recto superior drena directamente hacia la vena porta, filtrándose primero en el parénquima hepático.

Tema: ATLS P1

Subtema: VÍA AÉREA Y VENTILACIÓN

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 28 años, motociclista que sufre accidente a alta velocidad impactando su rostro directamente contra el pavimento (no portaba casco cerrado). Ingresa a la sala de choque con Glasgow de 6, cianosis peribucal, y un traumatismo maxilofacial severo (fracturas panfaciales múltiples, sangrado activo profuso en cavidad oral y destrucción de la anatomía mandibular). La saturación de oxígeno es del 78%. El anestesiólogo intenta la intubación orotraqueal directa en dos ocasiones pero resulta imposible ("no intubable, no ventilable") debido a la hemorragia masiva y la pérdida de las referencias anatómicas.

Pregunta 1

Ante este escenario catastrófico de "no intubable, no ventilable" en un paciente con trauma maxilofacial masivo, ¿cuál es el manejo definitivo de la vía aérea de rescate que debe realizarse de extrema urgencia en la sala de choque, según el protocolo ATLS?

A) Colocación de mascarilla laríngea

B) Intubación nasotraqueal a ciegas

C) Traqueostomía percutánea

D) Cricotiroidotomía quirúrgica *

Retroalimentación:

La cricotiroidotomía quirúrgica (incisión a través de la membrana cricotiroidea para colocar un tubo) es el acceso quirúrgico de elección en una situación de emergencia vital donde no se puede ventilar con mascarilla ni intubar por vía oral, especialmente cuando hay un trauma maxilofacial severo, edema glótico o sangrado orofaríngeo masivo. Es mucho más rápida y segura de realizar en urgencias que una traqueostomía formal.

Pregunta 2

Al realizar el abordaje inicial de la vía aérea ("A") en un paciente con trauma contuso severo, ¿cuál es la maniobra manual que está absolutamente contraindicada por el riesgo de seccionar la médula espinal ante una posible lesión de la columna cervical?

A) Subluxación mandibular (tracción mandibular)

B) Elevación del mentón

C) Hiperextensión del cuello (maniobra frente-mentón) *

D) Colocación de collarín cervical rígido

Retroalimentación:

En todo paciente traumatizado se asume una lesión de la columna cervical hasta demostrar lo contrario. La clásica maniobra de "frente-mentón" (hiperextensión del cuello) utilizada en el soporte vital básico está estrictamente contraindicada en trauma, ya que el movimiento del cuello puede desplazar una fractura cervical y seccionar la médula espinal. La maniobra indicada en trauma para abrir la vía aérea de forma segura es la tracción o subluxación mandibular, manteniendo la cabeza en posición neutra.

Tema: INTRODUCCIÓN OFTALMOLOGÍA

Subtema: RETINOPATÍA DEL PREMATURO

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Neonato prematuro nacido a las 27 semanas de gestación, con peso al nacer de 900 gramos. Durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), cursó con Síndrome de Dificultad Respiratoria tipo 1 (Enfermedad de membrana hialina), requiriendo intubación orotraqueal y ventilación mecánica con fracciones inspiradas de oxígeno (FiO2) elevadas y fluctuantes durante 4 semanas para mantener la saturación por arriba del 90%.

Pregunta 1

Considerando sus factores de riesgo (prematurez extrema, bajo peso e hiperoxia), el paciente está en alto riesgo de desarrollar retinopatía del prematuro (ROP). Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué provoca la exposición prolongada a altas concentraciones de oxígeno en la inmadura retina de este recién nacido?

A) Hemorragia subhialoidea masiva inmediata

B) Vasoconstricción retiniana severa inicial, seguida (al retirar el oxígeno) de hipoxia y proliferación vascular anómala (neovascularización) *

C) Desprendimiento traccional del epitelio pigmentario por depósito de fibrina

D) Infección oportunista por citomegalovirus (CMV)

Retroalimentación:

La retina del prematuro es inmadura y vascularmente incompleta. La hiperoxia (exceso de oxígeno suplementario) en la UCIN causa vasoconstricción y detención del crecimiento normal de los vasos retinianos. Posteriormente, al disminuir el oxígeno suplementario, esa retina avascular sufre hipoxia relativa, lo que dispara una sobreproducción de Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF), generando vasos sanguíneos nuevos pero anormales, frágiles y tortuosos (neovascularización) que finalmente sangran y causan desprendimiento de retina traccional.

Pregunta 2

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana y la GPC, para evitar la ceguera prevenible, ¿en qué momento exacto se debe realizar la primera exploración oftalmológica de tamizaje (fondo de ojo bajo dilatación pupilar) en este paciente?

A) Inmediatamente en la sala de partos al nacer

B) Al cumplir 1 año de edad corregida

C) A la 4ta semana de vida extrauterina (cronológica) o a las 31 semanas de edad gestacional corregida (lo que ocurra más tarde) *

D) Exclusivamente al momento de darle el alta de la UCIN

Retroalimentación:

El tamizaje universal para la retinopatía del prematuro es obligatorio en neonatos ≤ 34 semanas de gestación o peso ≤ 1750g (o en mayores si recibieron oxígeno y tuvieron inestabilidad clínica). La GPC dicta que el oftalmólogo debe realizar el primer fondo de ojo a la cuarta semana del nacimiento (vida cronológica) o a las 31 semanas de edad gestacional corregida, ya que es la ventana de tiempo donde la enfermedad (si se presenta) comenzará a ser visible pero aún tratable (con láser o anti-VEGF) antes del desprendimiento.

Shutterstock

Explorar

Tema: PATOLOGÍA DE EXTREMIDAD SUPERIOR

Subtema: EPICONDILITIS (CODO DE TENISTA Y GOLFISTA)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 45 años, de ocupación secretaria (uso intensivo de teclado y ratón) y jugadora recreativa de tenis. Acude a la consulta ortopédica refiriendo dolor insidioso en la cara lateral del codo derecho de 3 meses de evolución, el cual empeora al levantar objetos cotidianos (como una jarra de agua) o al exprimir un trapo. A la exploración física, hay dolor exquisito a la palpación directa de la prominencia ósea lateral del codo, y el dolor se exacerba notablemente cuando la paciente intenta realizar una extensión resistida de la muñeca.

Pregunta 1

Con el cuadro clínico característico de "Codo de tenista" (Epicondilitis lateral), ¿cuál es el tendón del músculo específico que se encuentra primariamente degenerado e inflamado en su origen óseo?

A) Tendón del bíceps braquial

B) Tendón del tríceps braquial

C) Tendón del músculo flexor radial del carpo

D) Tendón del músculo extensor radial corto del carpo (Extensor Carpi Radialis Brevis) *

Retroalimentación:

La epicondilitis lateral ("codo de tenista") es una tendinopatía degenerativa por sobreuso que afecta el origen de la musculatura extensora del antebrazo en el epicóndilo lateral del húmero. El tendón específicamente más afectado y responsable de la sintomatología clásica (dolor a la extensión resistida de la muñeca) es el del músculo extensor radial corto del carpo (ERCC). En contraste, la epicondilitis medial ("codo de golfista") afecta el origen de los músculos flexores y pronadores.

Tema: HIPOACUSIA Y VÉRTIGO

Subtema: VÉRTIGO POSTURAL PAROXÍSTICO BENIGNO (VPPB)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 55 años, sin antecedentes crónicos, acude a consulta refiriendo episodios de mareo intenso con sensación de que "el cuarto le da vueltas" (vértigo rotatorio). Menciona que estos episodios duran unos 15 a 30 segundos y se desencadenan exclusivamente cuando se acuesta en la cama y gira la cabeza hacia el lado derecho. Entre episodios se encuentra completamente asintomática. Niega pérdida de la audición, zumbidos (acúfenos) o dolor de oído.

Pregunta 1

Ante la sospecha del trastorno vestibular periférico más común, caracterizado por la presencia de otolitos en los canales semicirculares (usualmente el posterior), ¿cuál es la maniobra clínica diagnóstica de elección que reproducirá el vértigo y desencadenará un nistagmo torsional hacia el oído afectado?

A) Maniobra de Epley

B) Maniobra de Dix-Hallpike *

C) Prueba de Romberg

D) Maniobra de Semont

Retroalimentación:

El Vértigo Postural Paroxístico Benigno (VPPB) se diagnostica clínicamente mediante la maniobra de Dix-Hallpike. Al recostar rápidamente al paciente con la cabeza girada y colgando, se estimula el movimiento de los otolitos libres en el canal semicircular posterior, desencadenando un vértigo transitorio y un nistagmo característico (torsional y hacia arriba). La maniobra de Epley, por otro lado, es la maniobra terapéutica de reposicionamiento para curar el VPPB.

Tema: PATOLOGÍA INTESTINAL INFLAMATORIA

Subtema: COLITIS ULCEROSA CRÓNICA IDIOPÁTICA (CUCI)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 30 años acude a gastroenterología por presentar un cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por diarrea sanguinolenta (6 a 8 evacuaciones al día), pujo, tenesmo rectal, pérdida de peso de 5 kg y dolor abdominal tipo cólico en el cuadrante inferior izquierdo que alivia tras la defecación. Refiere episodios de fiebre intermitente. Sus laboratorios revelan anemia (Hb 10.5 g/dL), VSG elevada y PCR de 45 mg/L. Los coprocultivos y la búsqueda de amebas son negativos.

Pregunta 1

Se realiza una colonoscopia que revela una mucosa eritematosa, friable (sangra al roce del endoscopio) y con pérdida del patrón vascular, acompañada de múltiples úlceras superficiales. Esta afectación inicia en el recto y se extiende de manera continua y circunferencial hasta el colon transverso. Al tomar biopsias, ¿cuál es el hallazgo histopatológico característico de esta enfermedad?

A) Granulomas no caseificantes transmurales

B) Microabscesos en las criptas de Lieberkühn confinados a la mucosa *

C) Infiltrado inflamatorio parcheado con preservación del recto

D) Atrofia severa de las vellosidades intestinales

Retroalimentación:

A diferencia de la Enfermedad de Crohn (que es transmural, parcheada y con granulomas), la Colitis Ulcerosa Crónica Idiopática (CUCI) afecta exclusivamente la mucosa y submucosa, siempre inicia en el recto y asciende de manera continua. Su sello histológico patognomónico es la inflamación de la mucosa con distorsión de la arquitectura glandular y la formación de microabscesos crípticos (cúmulos de neutrófilos en las criptas).

Pregunta 2

¿Cuál es el marcador serológico de autoanticuerpos que resulta positivo en el 60-70% de los pacientes con CUCI, ayudando a diferenciarlo de la Enfermedad de Crohn (la cual suele ser ASCA positiva)?

A) Anticuerpos antinucleares (ANA)

B) Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos con patrón perinuclear (p-ANCA) *

C) Anticuerpos anti-mitocondriales (AMA)

D) Factor reumatoide (FR)

Retroalimentación:

Los p-ANCA (anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos con patrón de tinción perinuclear) son el marcador serológico más asociado al CUCI. En la Enfermedad de Crohn, el marcador serológico más frecuente son los ASCA (anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae).

Pregunta 3

Si este paciente evolucionara tórpidamente y presentara súbitamente fiebre de 39°C, taquicardia, distensión abdominal masiva y cese de las evacuaciones diarreicas, se debe sospechar de la complicación aguda más letal del CUCI (Megacolon tóxico). ¿Cuál es el estudio inicial y el criterio radiológico para confirmar esta urgencia quirúrgica?

A) Tomografía de abdomen; engrosamiento mural > 1 cm

B) Colonoscopia de urgencia; pérdida total de haustras

C) Radiografía simple de abdomen; dilatación del colon transverso > 6 cm *

D) Ultrasonido abdominal; líquido libre en cavidad

Retroalimentación:

El megacolon tóxico es una dilatación aguda no obstructiva del colon asociada a toxicidad sistémica. Su diagnóstico inicial se realiza con una simple radiografía de abdomen en decúbito, donde el hallazgo confirmatorio es la dilatación del colon (típicamente el colon transverso) con un diámetro mayor a 6 centímetros, a menudo acompañado de pérdida de las haustras y edema de la pared ("impresiones dactilares").

Tema: ATLS P2

Subtema: TCE ESCALA DE GLASGOW

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 25 años, ingresa a la sala de urgencias tras sufrir un accidente en motocicleta a alta velocidad sin portar casco. El paciente no obedece órdenes. A la evaluación primaria, el médico nota que el paciente abre los ojos únicamente cuando se le aplica un estímulo doloroso intenso en el lecho ungueal. No emite ninguna palabra, produciendo únicamente sonidos incomprensibles (gemidos). Al aplicar el estímulo doloroso, el paciente flexiona y rota internamente ambos brazos sobre el pecho de forma anormal, y extiende rígidamente las piernas.

Pregunta 1

Con base en la Escala de Coma de Glasgow (ECG) para adultos, ¿cuál es el puntaje correcto de este paciente?

A) 8 puntos

B) 7 puntos *

C) 6 puntos

D) 5 puntos

Retroalimentación:

El cálculo de la Escala de Coma de Glasgow se divide en tres respuestas:

Ocular (Apertura al dolor): 2 puntos.

Verbal (Sonidos incomprensibles): 2 puntos.

Motora (Flexión anormal / Rigidez de decorticación): 3 puntos.

Total: 2 + 2 + 3 = 7 puntos.

Pregunta 2

Según los protocolos del ATLS, ¿cuál es la medida definitiva para el manejo de la vía aérea indicada de manera inmediata en este paciente basado en su puntaje de Glasgow?

A) Colocación de cánula orofaríngea (Guedel) y observación

B) Oxígeno suplementario por mascarilla con reservorio a 15 lts/min

C) Intubación orotraqueal con secuencia rápida de inducción *

D) Cricotiroidotomía quirúrgica directa

Retroalimentación:

Un puntaje en la Escala de Coma de Glasgow igual o menor a 8 ("Glasgow de 8, entuba") clasifica el traumatismo craneoencefálico como SEVERO. Esto indica que el paciente ha perdido o está por perder los reflejos protectores de la vía aérea (tusígeno y nauseoso), por lo que la intubación orotraqueal temprana es una indicación absoluta y prioritaria para asegurar la vía aérea, prevenir la broncoaspiración y asegurar la normoventilación para evitar daño cerebral secundario por hipoxia.

Shutterstock

Tema: PATOLOGÍA GÁSTRICA

Subtema: HERNIA HIATAL / ERGE

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 45 años, con IMC de 32 (obesidad), acude a consulta por referir sensación de ardor retroesternal (pirosis) y regurgitación de sabor ácido que empeora al acostarse o al agacharse a atarse los zapatos, de 2 años de evolución. Refiere que últimamente ha presentado tos seca nocturna y disfonía matutina. Recibió un tratamiento empírico con Omeprazol 20 mg/día por 4 semanas con mejoría muy leve, por lo que regresó a consulta. Se le realizó una endoscopia superior que no mostró esofagitis erosiva ni úlceras (ERGE no erosivo).

Pregunta 1

Dado que la endoscopia fue negativa pero los síntomas persisten y son atípicos (tos, disfonía), ¿cuál es el estudio considerado el estándar de oro para confirmar el diagnóstico de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE)?

A) Serie esofagogastroduodenal con bario

B) Manometría esofágica

C) pH-metría esofágica de 24 horas (con o sin impedancia) *

D) Prueba de aliento para H. pylori

Retroalimentación:

La pH-metría esofágica ambulatoria de 24 horas es el estándar de oro para el diagnóstico de ERGE. Cuantifica exactamente cuántas veces y por cuánto tiempo el ácido gástrico refluye hacia el esófago inferior, y permite correlacionar estos episodios de reflujo ácido con los síntomas del paciente (como la tos nocturna), siendo indispensable en casos donde la endoscopia no muestra lesiones o antes de planear una cirugía antirreflujo.

Pregunta 2

Si en una futura endoscopia de seguimiento se encontrara el reemplazo del epitelio escamoso estratificado normal del esófago distal por un epitelio cilíndrico con células caliciformes (metaplasia intestinal), ¿a qué complicación premaligna grave del ERGE crónico correspondería este hallazgo?

A) Esófago de Barrett *

B) Anillo de Schatzki

C) Síndrome de Mallory-Weiss

D) Acalasia secundaria

Retroalimentación:

El Esófago de Barrett es una complicación directa de la irritación ácida crónica. El esófago distal se defiende cambiando su mucosa normal por una mucosa similar a la del intestino (metaplasia intestinal especializada). Es una lesión premaligna de gran importancia ya que predispone directamente al desarrollo de adenocarcinoma de esófago, por lo que requiere vigilancia endoscópica periódica con toma de biopsias para detectar displasia.

Tema: UROLOGÍA P1

Subtema: CRIPTORQUIDIA

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Lactante masculino de 12 meses de edad es traído a su consulta de control de niño sano. Su madre refiere que, desde el nacimiento, el escroto derecho "se ve más pequeño y vacío". A la exploración física en ambiente cálido, el testículo izquierdo se encuentra en la bolsa escrotal, de tamaño y consistencia normales. El testículo derecho no es palpable en la bolsa escrotal, sino que se palpa en el tercio distal del canal inguinal, siendo imposible descenderlo manualmente hasta el escroto.

Pregunta 1

De acuerdo con las guías urológicas pediátricas, al no haberse producido el descenso testicular espontáneo durante el primer año de vida, ¿cuál es el rango de edad ideal recomendado para realizar la corrección quirúrgica (orquidopexia) con el fin de maximizar la preservación de la fertilidad y facilitar la autoexploración futura?

A) Inmediatamente al nacimiento

B) Entre los 6 y 18 meses de edad *

C) Durante la pubertad (12 a 14 años)

D) Después de los 18 años

Retroalimentación:

El descenso testicular espontáneo es muy raro después de los 6 meses de edad. La GPC y la Asociación Americana de Urología indican que la orquidopexia (fijación quirúrgica del testículo en el escroto) debe realizarse idealmente entre los 6 y los 12-18 meses de edad. Operar a esta edad previene el daño histológico irreversible a las células germinales (preservando el potencial de fertilidad) y, aunque no elimina el riesgo inherente de desarrollar cáncer testicular en la edad adulta, permite colocar el testículo en una posición donde la autoexploración para detectar masas sea posible.

Tema: PATOLOGÍA PANCREÁTICA

Subtema: PANCREATITIS AGUDA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Femenina de 45 años, con antecedente de colelitiasis demostrada por ecografía hace un año, sin tratamiento quirúrgico. Es traída al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal de inicio súbito e intensidad 10/10 en el epigastrio, el cual se irradia en forma de "cinturón" (transfictivo) hacia la espalda. El cuadro se acompaña de náuseas y múltiples episodios de vómito de contenido gastroalimentario que no

alivian el dolor. A la exploración física: T 37.8°C, FC 115 lpm, TA 100/65 mmHg, FR 22 rpm. El abdomen se encuentra distendido, con disminución de los ruidos peristálticos, hiperestesia y dolor exquisito a la palpación profunda en el epigastrio, sin datos de irritación peritoneal franca. Laboratorios: Leucocitos 14,000/mm^3, Glucosa 180 mg/dL, Amilasa sérica 850 U/L (Valor normal < 140 U/L) y Lipasa sérica 1,200 U/L (Valor normal < 160 U/L). Pruebas de función hepática con elevación de AST (250 U/L) y ALT (310 U/L).

Pregunta 1

De acuerdo con los Criterios de Atlanta Revisados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el diagnóstico de pancreatitis aguda en esta paciente es correcta?

A) Se requiere forzosamente una Tomografía Computarizada de abdomen contrastada para confirmar el diagnóstico

B) El diagnóstico se confirma por la presencia de dolor característico y elevación de lipasa > 3 veces el límite superior normal *

C) La amilasa sérica es un marcador más específico y sensible que la lipasa para confirmar el diagnóstico

D) Se requiere la presencia de los signos de Cullen o Grey-Turner para establecer el diagnóstico clínico

Retroalimentación:

Los Criterios de Atlanta requieren 2 de 3 parámetros para diagnosticar pancreatitis aguda: 1) Dolor abdominal sugerente (epigastrio irradiado a la espalda), 2) Elevación de amilasa o lipasa sérica > 3 veces el límite superior normal, y 3) Hallazgos imagenológicos característicos. La paciente tiene clínica y laboratorios clásicos (lipasa > 3 veces el valor normal), por lo que el diagnóstico está confirmado sin necesidad de TAC en este momento. La lipasa es más sensible y específica que la amilasa.

Pregunta 2

Dado que el diagnóstico clínico y bioquímico ya está establecido, ¿cuál es el estudio de imagen inicial que la GPC recomienda solicitar en las primeras 24 horas en el servicio de urgencias para investigar la etiología de la pancreatitis?

A) Ultrasonido hepatobiliar de cuadrante superior derecho *

B) Tomografía axial computarizada de abdomen con contraste intravenoso

C) Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE)

D) Resonancia magnética de abdomen

Retroalimentación:

El ultrasonido abdominal es el estudio de imagen inicial de elección en todos los pacientes con pancreatitis aguda. Su principal objetivo en las primeras horas no es evaluar el páncreas (que a menudo no se ve por el gas intestinal), sino buscar litos en la vesícula biliar o dilatación del colédoco, ya que la etiología biliar es la causa número uno de pancreatitis en nuestro medio (apoyada en esta paciente por la elevación de ALT > 150 U/L). La TAC contrastada se reserva para después de 72 horas si hay deterioro clínico o sospecha de necrosis.

Pregunta 3

Considerando que la paciente se encuentra en las primeras 12 a 24 horas de evolución y presenta signos iniciales de respuesta inflamatoria sistémica (taquicardia, leucocitosis), ¿cuál es el pilar terapéutico inicial más importante para prevenir la necrosis pancreática y disminuir la mortalidad?

A) Inicio inmediato de antibióticos profilácticos de amplio espectro (Imipenem)

B) Ayuno prolongado por un mínimo de 7 días

C) Reanimación hídrica agresiva con cristaloides (Ringer Lactato) monitorizada *

D) Cirugía de urgencia para necrosectomía pancreática

Retroalimentación:

La piedra angular del tratamiento en las primeras 12-24 horas de la pancreatitis aguda es la reanimación con líquidos intravenosos agresiva (preferentemente Ringer Lactato). La inflamación pancreática produce un secuestro masivo de líquidos en el tercer espacio, llevando a hipovolemia, hemoconcentración y disminución de la microperfusión pancreática, lo cual es la causa principal del desarrollo de necrosis. El uso de antibióticos profilácticos está contraindicado en pancreatitis aguda (solo se usan si hay necrosis infectada o colangitis demostrada).

Tema: PATOLOGÍA INFECCIOSA / RINOLOGÍA Y FARINGE

Subtema: EPIGLOTITIS

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Preescolar masculino de 4 años, no cuenta con cartilla de vacunación actualizada debido a creencias familiares. Es llevado al servicio de urgencias pediátricas por presentar un cuadro de inicio abrupto (hace 8 horas) caracterizado por fiebre de 39.5°C, dificultad progresiva para respirar y dolor de garganta intenso (odinofagia). A la inspección, el niño luce ansioso, tóxico, babeando profusamente (sialorrea) porque es incapaz de tragar su propia saliva. Adopta una postura característica: sentado, inclinado hacia adelante con el cuello hiperextendido y la mandíbula protruida (posición en trípode). Presenta estridor inspiratorio suave.

Pregunta 1

Ante este cuadro clásico que representa una verdadera urgencia de la vía aérea en un niño no inmunizado, ¿cuál es el agente etiológico bacteriano clásicamente responsable de esta enfermedad?

A) Streptococcus pyogenes (Grupo A)

B) Haemophilus influenzae tipo b (Hib) *

C) Virus Sincitial Respiratorio (VSR)

D) Corynebacterium diphtheriae

Retroalimentación:

La epiglotitis aguda clásica es una celulitis bacteriana supraglótica rápidamente progresiva y potencialmente fatal, históricamente causada casi en su totalidad por Haemophilus influenzae tipo b (Hib). Aunque la incidencia ha disminuido drásticamente gracias a la vacuna pentavalente/hexavalente, sigue viéndose en niños no vacunados. Las "4 D's" clásicas en inglés son: Drooling (sialorrea), Dysphagia (disfagia), Dysphonia (voz apagada o en "papa caliente") y Distress (dificultad respiratoria en trípode).

Pregunta 2

Si el paciente se encuentra estable y la vía aérea no está inminentemente comprometida, permitiendo tomar una radiografía lateral de cuello (siempre en presencia de un experto en vía aérea), ¿cuál es el signo radiológico clásico patognomónico que confirmaría el diagnóstico?

A) Signo de la aguja o "campanario"

B) Signo del dedo pulgar (Thumbprint sign) *

C) Borramiento del espacio retrofaríngeo

D) Imagen en "cuenta de rosario"

Retroalimentación:

El signo del "dedo pulgar" en la radiografía lateral de tejidos blandos del cuello es patognomónico de la epiglotitis. Representa una epiglotis masivamente edematizada e inflamada que, en lugar de verse como una línea delgada y curva, se ve como una sombra redondeada y gruesa que simula la yema de un dedo pulgar humano, obstruyendo el paso del aire. El signo de la aguja es clásico del Croup (Laringotraqueítis viral).

Tema: UROLOGÍA P2

Subtema: LITIASIS RENAL

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 35 años, de oficio taxista (baja ingesta de líquidos), acude a urgencias quejándose de dolor severo (10/10), de tipo cólico, que inició de manera súbita en la fosa lumbar derecha y se irradia hacia la fosa ilíaca derecha y el testículo ipsilateral. El paciente no encuentra una posición que le alivie el dolor y se mueve constantemente en la camilla. Presenta náuseas, vómito y diaforesis. Su examen general de orina mediante tira reactiva demuestra microhematuria (++). No tiene fiebre ni datos de choque.

Pregunta 1

Ante la alta sospecha clínica de un cólico reno-ureteral, ¿cuál es el estudio de imagen de elección (Gold Standard) en el servicio de urgencias por su altísima sensibilidad (cercana al 100%) y especificidad para detectar y localizar cálculos en el tracto urinario, sin importar su composición química?

A) Radiografía simple de abdomen (KUB)

B) Ultrasonido renal y de vías urinarias

C) Tomografía computarizada (UroTAC) de abdomen y pelvis sin medio de contraste *

D) Pielografía intravenosa

Retroalimentación:

La Tomografía Computarizada simple (UroTAC sin contraste) es el estándar de oro absoluto para el diagnóstico de la litiasis urinaria en un episodio agudo. Es superior al ultrasonido y a la radiografía porque detecta los cálculos (incluso los radiolúcidos de ácido úrico que no se ven en la radiografía simple), determina su tamaño exacto, su ubicación (cáliz, pelvis, uréter) y permite medir su dureza en Unidades Hounsfield para planear el tratamiento.

Tema: PATOLOGÍA PERIANAL

Subtema: HEMORROIDES

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 50 años, con antecedente de estreñimiento crónico. Acude a la consulta externa de cirugía general por presentar sangrado transrectal intermitente desde hace 6 meses. Refiere que el sangrado es de color rojo brillante, sin coágulos, y se presenta típicamente como gotas al final de la evacuación o manchando el papel higiénico. Lo que más le preocupa es que, después de defecar, siente que "una masa se sale por el ano" (prolapso). Menciona que esta masa no regresa sola hacia adentro, sino que debe empujarla y reintroducirla con sus propios dedos (reducción manual), tras lo cual se queda en su lugar. Niega dolor intenso anal, fiebre o pérdida de peso.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación clínica de Goligher para la enfermedad hemorroidal interna, ¿en qué grado se clasifica la patología de este paciente?

A) Grado I

B) Grado II

C) Grado III *

D) Grado IV

Retroalimentación:

La clasificación de Goligher estatifica las hemorroides internas según su grado de prolapso.

Grado I: Sangran pero no prolapsan.

Grado II: Prolapsan al defecar pero se reducen espontáneamente solas.

Grado III: Prolapsan al defecar y requieren reducción manual por el paciente para volver a su lugar (como en este caso).

Grado IV: Permanecen prolapsadas todo el tiempo y son irreductibles manualmente.

Shutterstock

Explorar

Pregunta 2

Según la GPC mexicana, y dado que la enfermedad hemorroidal del paciente se encuentra en este grado avanzado que afecta su calidad de vida y no respondió a medidas conservadoras previas, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de elección?

A) Fotocoagulación con láser infrarrojo

B) Ligadura con banda elástica en consultorio

C) Escleroterapia inyectada

D) Hemorroidectomía escisional (técnica cerrada de Ferguson o abierta de Milligan-Morgan) *

Retroalimentación:

El tratamiento quirúrgico definitivo, la hemorroidectomía escisional (cortar y extraer el plexo hemorroidal enfermo), es el estándar de oro y la indicación de elección para las hemorroides internas Grado III y Grado IV, o aquellas que presentan sangrado intratable. La ligadura con banda elástica, fotocoagulación y escleroterapia están

reservadas e indicadas como tratamiento de primera línea para las hemorroides internas Grado I y II.

Tema: ATLS P2

Subtema: TCE HEMORRAGIA EPIDURAL

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 22 años es llevado a urgencias por paramédicos tras participar en una riña callejera donde recibió un golpe directo con un bate de béisbol en la región temporal derecha (pterion). Los paramédicos reportan que, inmediatamente tras el golpe, el paciente perdió el conocimiento durante un par de minutos, pero luego despertó y estuvo lúcido, hablando y caminando durante el traslado (intervalo lúcido). A su llegada a urgencias (40 minutos después), el paciente se deteriora bruscamente, cayendo en estado de coma (Glasgow 6). A la exploración neurológica, presenta la pupila derecha completamente dilatada (midriasis arreactiva) y parálisis motora (hemiparesia) del lado izquierdo.

Pregunta 1

Ante la cinemática del trauma (golpe temporal), la clásica presentación clínica de "intervalo lúcido" seguido de deterioro rápido y datos de herniación uncal, ¿cuál será el hallazgo tomográfico y el vaso sanguíneo responsable que confirman este diagnóstico?

A) Colección cóncavo-convexa (semiluna) originada por ruptura de venas puente

B) Sangre en las cisternas basales y ventrículos por ruptura de un aneurisma

C) Hemorragia intraparenquimatosa frontal por contusión cerebral pura

D) Colección biconvexa (lenticular) que no cruza suturas, originada por ruptura de la arteria meníngea media *

Retroalimentación:

El hematoma epidural es causado clásicamente por la fractura del hueso temporal (región del pterion) que secciona o desgarra la arteria meníngea media. Debido a que el sangrado es de origen arterial (alta presión), diseca rápidamente la duramadre despegándola del cráneo. La sangre se acumula rápidamente adoptando una

característica forma de lente biconvexo (limón) en la TAC, delimitada por las suturas craneales (no puede cruzarlas). La presentación en tres fases (pérdida de conciencia inicial - intervalo lúcido - coma por herniación cerebral rápida) es su sello clínico patognomónico.